

Santé publique — Introduction à la santé publique

QRM d'entraînement — 100 questions, 5 séries de 20 — SUJET

Série 1 — Questions 1 à 20

1. Concernant les différentes définitions de la santé et de sa promotion :

- a) Selon Blum, la santé consiste notamment à se comporter d'une façon qui permette la survie de l'espèce ainsi que l'accomplissement personnel ou le contentement de l'individu.
- b) Selon le microbiologiste R. Dubos, la santé se définit uniquement par des critères mentaux, indépendamment de l'état physique.
- c) Selon Steichen, la santé correspond à la normalité avec ses caractéristiques.
- d) Selon la Conférence d'Ottawa (1986), la promotion de la santé désigne exclusivement les campagnes de communication gouvernementales sur la santé.
- e) Le Dry January et le mois sans tabac en novembre sont cités comme exemples de campagnes de promotion de la santé.

2. Concernant les sources de données en santé publique :

- a) Les informations des registres des cancers proviennent des anatomo-pathologistes, des biologistes et des cliniciens.
- b) Il existe 14 registres des cancers en France, tous généraux, sans registre spécialisé.
- c) Le big data en santé se caractérise par une diminution du volume de données disponibles.
- d) Le CépiDc est un registre exclusivement dédié aux cancers colorectaux.
- e) Les maladies à déclaration obligatoire (MDO) et les données démographiques (Insee, INED) font partie des sources de données en santé publique en France.

3. Concernant l'espérance de vie :

- a) En France, l'espérance de vie est uniforme sur l'ensemble du territoire, sans disparité régionale.
- b) L'écart d'espérance de vie entre hommes et femmes s'est progressivement réduit, passant de 7,8 ans en 1997 à 5,9 ans en 2022.
- c) L'espérance de vie désigne l'âge maximal théorique que peut atteindre un individu.
- d) En 2024, l'espérance de vie féminine en France était la plus élevée d'Europe, devant l'Espagne et l'Allemagne.
- e) En France en 2023, l'espérance de vie à la naissance était identique pour les hommes et les femmes, à 82,8 ans.

4. Dans une région, on dénombre 280 000 naissances vivantes sur une année, parmi lesquelles 980 enfants sont décédés avant l'âge de 1 an.

- a) Le taux de mortalité infantile de cette région est de 3,5 ‰.
- b) Le taux de mortalité infantile de cette région est de 35,0 ‰.
- c) Le taux de mortalité infantile se calcule en rapportant le nombre de décès avant 1 an au nombre de naissances vivantes.
- d) Le taux de mortalité infantile se calcule en rapportant le nombre de décès avant 1 an à la population totale.
- e) Le taux national de mortalité infantile était de 4,1 ‰ en France en 2024.

5. Concernant l'histoire et la structuration de la santé publique :

- a) La vaccination contre la variole a été mise au point par Louis Pasteur en 1848, sur le principe de pasteurisation.
- b) La loi relative à la protection de la santé publique, en 1902, a introduit le concept de santé publique en France.
- c) Les hôpitaux-Dieu étaient des établissements créés au 19e siècle par l'État pour la recherche médicale.
- d) Le courant hygiéniste (19e-début 20e siècle) correspond à l'abandon des mesures d'hygiène au profit de traitements uniquement curatifs.
- e) L'épidémie de peste noire a débuté en 1347 à Séville et a causé moins de 5 % de décès en Europe.

6. Concernant la morbidité et les indicateurs de morbidité :

- a) Le taux de reproduction, noté R, correspond aux cas secondaires engendrés par un cas et informe sur la contagiosité de la maladie.
- b) La mortalité, et non l'incidence, est l'indicateur qui permet de savoir s'il y a épidémie ou non.
- c) Selon l'enquête Insee 2002-2003, les hommes se trouvent plus souvent en très bonne santé que les femmes.
- d) Les hommes déclarent davantage souffrir de maladies que les femmes, en cohérence avec une prévalence plus élevée chez eux.
- e) La morbidité fait référence exclusivement aux décès, sans lien avec les maladies.

7. Dans un département de 975 000 habitants, on dénombre 8 287 décès sur l'année.

- a) Le taux brut de mortalité de ce département est de 8,5 ‰.
- b) Le taux brut de mortalité de ce département est de 85,0 ‰.
- c) Le taux brut de mortalité se calcule en divisant le nombre de décès par la population.
- d) Le taux brut de mortalité se calcule en divisant le nombre de décès par le nombre de naissances vivantes.
- e) Comparé au taux brut de mortalité national (9,4 ‰ en 2023 et 2024), le taux de ce département est plus faible.

8. Concernant les différentes définitions de la santé et de sa promotion :

- a) Le concept de santé positive met l'accent sur l'hypothèse d'un développement progressif de la maladie en étapes.
- b) Selon la Charte d'Ottawa, la santé est perçue comme une ressource de la vie quotidienne, et non comme le but de la vie.
- c) Selon l'OMS, la santé se définit exclusivement par l'absence de maladie ou d'infirmité.
- d) La frontière entre le normal et le pathologique varie avec l'âge, la culture et l'état de la science.
- e) Selon Blum, la santé consiste notamment à se comporter d'une façon qui permette la survie de l'espèce ainsi que l'accomplissement personnel ou le contentement de l'individu.

9. Concernant les missions et la définition de la santé publique :

- a) Selon l'OMS (1952), organiser des services médicaux et infirmiers en vue du diagnostic précoce et du traitement préventif des maladies fait partie de l'action collective concertée.
- b) En tant que discipline autonome, la santé publique s'occupe de l'état de santé d'une collectivité, d'un groupe ou d'un collectif.
- c) Selon l'OMS (1952), la santé publique vise notamment à prévenir les maladies, prolonger la vie et améliorer la santé par le moyen d'une action collective concertée.
- d) Dans la règle des 5P, la Prévention vise à éviter la survenue de maladies, par exemple par la vaccination ou le dépistage.
- e) Selon l'OMS (2002), la santé publique est l'ensemble des efforts par des institutions publiques dans une société pour améliorer, promouvoir, protéger et restaurer la santé de la population.

10. Concernant les définitions de la santé :

- a) Selon le chirurgien René Leriche (1936), « la santé c'est la vie dans le bruit des organes ».
- b) Dans le cadre de la santé positive, l'empowerment désigne l'accroissement de l'efficacité individuelle et des appuis sociaux.
- c) Selon Cotton (1982), la vie peut être considérée comme un rythme continu d'interactions et un état d'équilibre instable.
- d) Selon l'OMS, la santé est la finalité ultime de la vie, un but à atteindre et non une ressource.
- e) La santé positive privilégie des stratégies ciblées sur un déterminant unique, à l'exclusion de toute combinaison.

11. Concernant l'histoire et la structuration de la santé publique :

- a) Louis Pasteur est associé à l'hypothèse d'agents à l'origine des épidémies, à la pasteurisation et à l'asepsie chirurgicale.
- b) Le courant hygiéniste (19e-début 20e siècle) correspond à l'émergence de l'épidémiologie, de l'hygiène et de la prévention.
- c) L'épidémie de peste noire a débuté en 1347 à Marseille et a causé 30 à 50 % de décès en Europe.
- d) Le Serment d'Hippocrate concerne exclusivement l'organisation administrative des hôpitaux modernes.
- e) Les hôtels-Dieu étaient des établissements créés au 19e siècle par l'État pour la recherche médicale.

12. Concernant les indicateurs de santé :

- a) La fiabilité (ou reproductibilité) fait partie des propriétés des indicateurs de santé.
- b) Les indicateurs de santé ne sont utiles qu'à la recherche étiologique, sans lien avec la prise de décision.
- c) Les seuls types d'indicateurs de santé reconnus par le cours sont la mortalité et la morbidité.
- d) Les indicateurs de santé sont réservés à l'usage exclusif des cliniciens en cabinet privé.
- e) Un indicateur de santé est une donnée brute individuelle, non agrégée, propre à un seul patient.

13. Concernant les différentes définitions de la santé et de sa promotion :

- a) Selon Canguilhem, la santé est la marge de tolérance aux infidélités du milieu, le volant régulateur des possibilités de réactions.
- b) Selon le sociologue R. Bastide, l'homme sain est celui qui s'ajuste passivement à toute évolution du monde sans jamais le modifier.
- c) Le Dry January et le mois sans tabac en novembre sont cités comme exemples de campagnes de promotion de la santé.
- d) Selon l'OMS, la santé est uniquement un état de bien-être physique, sans dimension mentale ni sociale.
- e) Selon Canguilhem, « la santé a remplacé le salut » et être en bonne santé est « un luxe biologique ».

14. Concernant les définitions de la santé :

- a) Selon Canguilhem, la santé est la marge de tolérance aux infidélités du milieu, le volant régulateur des possibilités de réactions.
- b) Selon le Petit Robert, la santé est un bon état physiologique, un fonctionnement régulier et harmonieux de l'organisme humain pendant une période appréciable.
- c) D'un point de vue physiologique, la santé ne peut être définie par aucune norme du fonctionnement physique ou biologique.
- d) Selon le chirurgien René Leriche (1936), « la santé c'est la vie dans le silence des organes ».
- e) Selon l'OMS, la santé se définit exclusivement par l'absence de maladie ou d'infirmité.

15. Dans une région, on dénombre 520 000 naissances vivantes sur une année, parmi lesquelles 2 236 enfants sont décédés avant l'âge de 1 an.

- a) Le taux de mortalité infantile de cette région est de 4,3 ‰.
- b) Le taux de mortalité infantile de cette région est de 43,0 ‰.
- c) Le taux de mortalité infantile se calcule en rapportant le nombre de décès avant 1 an au nombre de naissances vivantes.
- d) Le taux de mortalité infantile se calcule en rapportant le nombre de décès avant 1 an à la population totale.
- e) Le taux national de mortalité infantile était de 4,1 ‰ en France en 2024.

16. Dans une région, on dénombre 410 000 naissances vivantes sur une année, parmi lesquelles 1 722 enfants sont décédés avant l'âge de 1 an.

- a) Le taux de mortalité infantile de cette région est de 4,2 ‰.
- b) Le taux de mortalité infantile de cette région est de 42,0 ‰.
- c) Le taux de mortalité infantile se calcule en rapportant le nombre de décès avant 1 an au nombre de naissances vivantes.
- d) Le taux de mortalité infantile se calcule en rapportant le nombre de décès avant 1 an à la population totale.
- e) Le taux national de mortalité infantile était de 4,1 ‰ en France en 2024.

17. Concernant la morbidité et les indicateurs de morbidité :

- a) La mortalité, en épidémiologie descriptive, correspond au nombre de décès, mesuré par des indicateurs de mortalité brute ou spécifique.
- b) La portion de population se trouvant en très bonne santé augmente continûment avec l'âge.
- c) La létalité correspond au nombre de décès parmi les malades, et informe sur la gravité de la maladie.
- d) Comparés aux femmes, les hommes déclarent moins souffrir d'une maladie, alors qu'ils sont pourtant les plus atteints de maladies.
- e) L'incidence correspond au nombre de décès parmi les malades, et informe sur la gravité de la maladie.

18. Dans un pays fictif, l'indice synthétique de fécondité (ISF) est de 1,9, sans apport migratoire notable.

- a) Cet ISF est inférieur au seuil de remplacement de 2,1.
- b) Cet ISF est supérieur au seuil de remplacement de 2,1.
- c) Une diminution de la population à long terme est possible dans ce contexte, sans apport migratoire.
- d) Le remplacement des générations est garanti dans ce contexte, sans apport migratoire.
- e) L'indice synthétique de fécondité désigne le nombre d'enfants par femme.

19. Concernant la prévalence, l'incidence et la létalité :

- a) Les hommes déclarent davantage souffrir de maladies que les femmes, en cohérence avec une prévalence plus élevée chez eux.
- b) Les 3 types de morbidité sont la morbidité ressentie, la morbidité diagnostiquée et la morbidité réelle.
- c) La létalité correspond au nombre de cas à un moment donné, et informe sur l'importance quantitative de la maladie.
- d) La prévalence correspond exclusivement au nombre de nouveaux cas sur une période de temps.
- e) L'incidence correspond au nombre de décès parmi les malades, et informe sur la gravité de la maladie.

20. Dans un département de 690 000 habitants, on dénombre 5 520 décès sur l'année.

- a) Le taux brut de mortalité de ce département est de 8,0 ‰.
- b) Le taux brut de mortalité de ce département est de 80,0 ‰.
- c) Le taux brut de mortalité se calcule en divisant le nombre de décès par la population.
- d) Le taux brut de mortalité se calcule en divisant le nombre de décès par le nombre de naissances vivantes.
- e) Comparé au taux brut de mortalité national (9,4 ‰ en 2023 et 2024), le taux de ce département est plus faible.

Série 2 — Questions 21 à 40

21. Concernant les indicateurs de santé :

- a) La fiabilité (ou reproductibilité) est présentée comme une propriété exclusive des seuls indicateurs de mortalité.
- b) Un indicateur de santé est un instrument de mesure grâce auquel des ensembles d'informations ou de données vont être agrégés, simplifiés ou résumés.
- c) Les indicateurs de santé sont réservés à l'usage exclusif des cliniciens en cabinet privé.
- d) Les indicateurs de santé fournissent des éléments indispensables à la connaissance de l'importance des problèmes de santé, à la prise de décision et à l'orientation de la recherche étiologique.
- e) Les seuls types d'indicateurs de santé reconnus par le cours sont la mortalité et la morbidité.

22. Concernant la règle des 5P et la santé publique :

- a) Dans la règle des 5P, la Prévision vise à surveiller les maladies et les risques pour la santé.
- b) La règle des 5P regroupe la Protection, la Prévention, la Promotion, la Prévision et la Provision.
- c) Selon l'OMS (1952), organiser des services médicaux et infirmiers en vue du diagnostic précoce et du traitement préventif des maladies fait partie de l'action collective concertée.
- d) Selon l'OMS (1952), la santé publique repose exclusivement sur l'action individuelle de chaque patient, sans dimension collective.
- e) En tant que discipline autonome, la santé publique s'occupe de l'état de santé d'une collectivité, d'un groupe ou d'un collectif.

23. Dans un département de 4 120 000 habitants, on dénombre 41 200 décès sur l'année.

- a) Le taux brut de mortalité de ce département est de 10,0 ‰.
- b) Le taux brut de mortalité de ce département est de 100,0 ‰.
- c) Le taux brut de mortalité se calcule en divisant le nombre de décès par la population.
- d) Le taux brut de mortalité se calcule en divisant le nombre de décès par le nombre de naissances vivantes.
- e) Comparé au taux brut de mortalité national (9,4 ‰ en 2023 et 2024), le taux de ce département est plus élevé.

24. Concernant la définition de la santé selon l'OMS et son évolution :

- a) Dans le cadre de la santé positive, l'empowerment désigne la diminution de l'autonomie individuelle au profit d'un contrôle institutionnel.
- b) D'un point de vue physiologique, la santé correspond à des normes du fonctionnement physique et biologique (poids, mesures, capacités visuelle, auditive, respiratoire...).
- c) Selon Canguilhem, la notion de santé n'a jamais eu de rapport avec la notion religieuse de salut.
- d) Selon le chirurgien René Leriche (1936), « la santé c'est la vie dans le silence des organes ».
- e) Selon l'OMS, la santé se définit exclusivement par l'absence de maladie ou d'infirmité.

25. Concernant la mortalité en France :

- a) À partir de 65 ans, les décès sont considérés comme naturels et liés au vieillissement.
- b) Entre 1980 et 2004, les décès liés aux maladies tumorales et aux cancers ont diminué aussi fortement que ceux liés aux maladies cardiovasculaires.
- c) En 2022, le nombre de décès en France a fortement diminué par rapport aux années précédentes, sans lien avec des causes sanitaires particulières.
- d) Pour la première fois en 2025, le nombre de décès en France a dépassé le nombre de naissances, une inversion non observée depuis la guerre.
- e) En France, on compte 600 000 à 650 000 décès par an, avec 600 000 décès en 2024 (diminution par rapport à 2023).

26. Concernant la complémentarité entre médecine clinique et santé publique :

- a) La santé publique fait la promotion de la santé et prévient l'apparition des maladies, par l'épidémiologie, l'administration de la santé et la sociologie.
- b) Selon C. Everett Koop, les soins de santé (health care) sont vitaux à tous, tout le temps, alors que la santé publique ne l'est qu'occasionnellement.
- c) La médecine clinique prend en charge une personne, ce que le cours nomme un « colloque singulier ».
- d) Les maladies d'importation et la réémergence de maladies sont citées comme des conséquences de la mondialisation.
- e) Les indicateurs de santé sont présentés comme une conséquence de la mondialisation, au même titre que les maladies d'importation.

27. Concernant la mortalité en France :

- a) Avant 65 ans, les décès sont systématiquement considérés comme naturels et liés au vieillissement.
- b) La mortalité toutes causes des femmes est plus importante que celle des hommes, sauf après 65 ans.
- c) En 2022, les tumeurs représentaient environ 27 % des décès en France et étaient la première cause de mortalité chez les hommes.
- d) Entre 1980 et 2004, les décès liés aux maladies tumorales et aux cancers sont restés d'une très grande stabilité.
- e) Le taux de mortalité infantile en France est en augmentation, passant de 3,6 ‰ en 2018 à 4,1 ‰ en 2024.

28. Concernant les définitions de la santé :

- a) Selon le microbiologiste R. Dubos, la santé est un état physique et mental relativement exempt de gêne et de souffrance.
- b) Selon l'OMS, la santé est la finalité ultime de la vie, un but à atteindre et non une ressource.
- c) D'un point de vue physiologique, la santé ne peut être définie par aucune norme du fonctionnement physique ou biologique.
- d) Selon la Conférence d'Ottawa (1986), la promotion de la santé est le processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et de l'améliorer.
- e) Selon l'OMS, la santé est uniquement un état de bien-être physique, sans dimension mentale ni sociale.

29. Dans une commune, on recense 340 cas d'une maladie chronique au 1er janvier de l'année (nombre de cas à cette date), puis 95 nouveaux cas sont diagnostiqués au cours de cette même année.

- a) Le nombre de 340 cas recensés au 1er janvier correspond à la prévalence.
- b) Le nombre de 340 cas recensés au 1er janvier correspond à l'incidence.
- c) Le nombre de 95 nouveaux cas diagnostiqués dans l'année correspond à l'incidence.
- d) Le nombre de 95 nouveaux cas diagnostiqués dans l'année correspond à la létalité.
- e) L'incidence de cette maladie permet notamment de savoir s'il y a épidémie ou non.

30. Concernant les définitions de la santé :

- a) D'un point de vue physiologique, la santé correspond à des normes du fonctionnement physique et biologique (poids, mesures, capacités visuelle, auditive, respiratoire...).
- b) Selon Cotton (1982), la vie peut être considérée comme un rythme continu d'interactions et un état d'équilibre instable.
- c) Selon l'OMS, la santé se définit exclusivement par l'absence de maladie ou d'infirmité.
- d) Selon Blum, la santé consiste notamment à se comporter d'une façon qui permette la survie de l'espèce ainsi que l'accomplissement personnel ou le contentement de l'individu.
- e) Selon la Charte d'Ottawa, la santé est perçue comme une ressource de la vie quotidienne, et non comme le but de la vie.

31. Concernant les différentes définitions de la santé et de sa promotion :

- a) Selon l'OMS, la santé est la finalité ultime de la vie, un but à atteindre et non une ressource.
- b) Selon Blum, la santé consiste exclusivement en la survie de l'espèce, sans lien avec l'accomplissement personnel de l'individu.
- c) La santé positive met l'accent sur l'importance de stratégies larges, prenant en compte une combinaison de déterminants.
- d) Selon le chirurgien René Leriche (1936), « la santé c'est la vie dans le bruit des organes ».
- e) Selon Canguilhem, la notion de santé n'a jamais eu de rapport avec la notion religieuse de salut.

32. Concernant les missions et la définition de la santé publique :

- a) Selon l'OMS (1952), la santé publique vise notamment à prévenir les maladies, prolonger la vie et améliorer la santé par le moyen d'une action collective concertée.
- b) Selon l'OMS (2002), la santé publique est l'ensemble des efforts par des institutions publiques dans une société pour améliorer, promouvoir, protéger et restaurer la santé de la population.
- c) Dans la règle des 5P, la Prévision vise à surveiller les maladies et les risques pour la santé.
- d) Selon l'OMS (1952), l'organisation de services médicaux n'est pas mentionnée parmi les actions de santé publique.
- e) Selon l'OMS (1952), l'objet final de la santé publique est de réduire les dépenses de l'État en matière de santé.

33. Dans un pays fictif, l'indice synthétique de fécondité (ISF) est de 1,6, sans apport migratoire notable.

- a) Cet ISF est inférieur au seuil de remplacement de 2,1.
- b) Cet ISF est supérieur au seuil de remplacement de 2,1.
- c) Une diminution de la population à long terme est possible dans ce contexte, sans apport migratoire.
- d) Le remplacement des générations est garanti dans ce contexte, sans apport migratoire.
- e) L'indice synthétique de fécondité désigne le nombre d'enfants par femme.

34. Concernant les causes de mortalité en France :

- a) À partir de 65 ans, les décès sont considérés comme naturels et liés au vieillissement.
- b) En France, on compte 600 000 à 650 000 décès par an, avec 646 000 décès en 2024 (augmentation de 6 700 par rapport à 2023).
- c) Le taux de mortalité infantile en France est en diminution constante depuis 2018.
- d) En 2023, le nombre de décès en France a augmenté de 5,3 % par rapport à l'année précédente.
- e) Pour la première fois en 2025, le nombre de décès en France a dépassé le nombre de naissances, une inversion non observée depuis la guerre.

35. Concernant l'espérance de vie :

- a) L'espérance de vie à 35 ans est identique pour les hommes cadres et les hommes ouvriers, à 40 ans.
- b) En 2024, l'espérance de vie féminine en France était la plus élevée d'Europe, devant l'Espagne et l'Allemagne.
- c) L'espérance de vie désigne l'âge maximal théorique que peut atteindre un individu.
- d) Des baisses brutales de l'espérance de vie sont observées lors des grandes guerres, particulièrement chez les hommes, suivies d'une reprise rapide.
- e) L'écart d'espérance de vie entre hommes et femmes s'est progressivement creusé, passant de 5,9 ans en 1997 à 7,8 ans en 2022.

36. Concernant la définition de la santé selon l'OMS et son évolution :

- a) Selon Blum, la santé consiste notamment à se comporter d'une façon qui permette la survie de l'espèce ainsi que l'accomplissement personnel ou le contentement de l'individu.
- b) Le concept de santé positive met l'accent sur l'hypothèse d'un développement progressif de la maladie en étapes.
- c) La santé positive met l'accent sur l'importance de stratégies larges, prenant en compte une combinaison de déterminants.
- d) La frontière entre le normal et le pathologique varie avec l'âge, la culture et l'état de la science.
- e) Selon Canguilhem, la notion de santé n'a jamais eu de rapport avec la notion religieuse de salut.

37. Dans un département de 2 150 000 habitants, on dénombre 20 640 décès sur l'année.

- a) Le taux brut de mortalité de ce département est de 9,6 ‰.
- b) Le taux brut de mortalité de ce département est de 96,0 ‰.
- c) Le taux brut de mortalité se calcule en divisant le nombre de décès par la population.
- d) Le taux brut de mortalité se calcule en divisant le nombre de décès par le nombre de naissances vivantes.
- e) Comparé au taux brut de mortalité national (9,4 ‰ en 2023 et 2024), le taux de ce département est plus élevé.

38. Concernant l'espérance de vie :

- a) En France en 2023, l'espérance de vie à la naissance était identique pour les hommes et les femmes, à 82,8 ans.
- b) L'espérance de vie à 35 ans est identique pour les hommes cadres et les hommes ouvriers, à 40 ans.
- c) En France, l'espérance de vie est uniforme sur l'ensemble du territoire, sans disparité régionale.
- d) L'écart d'espérance de vie entre hommes et femmes s'est progressivement creusé, passant de 5,9 ans en 1997 à 7,8 ans en 2022.
- e) En 2024, l'espérance de vie féminine en France (85,8 ans) était supérieure à celle de l'Allemagne, mais inférieure à celle de l'Espagne.

39. Au cours d'une épidémie, 150 personnes ont été atteintes par une maladie donnée ; parmi elles, 45 en sont décédées.

- a) La létalité de cette maladie, dans cette population, est de 30,0 %.
- b) La létalité de cette maladie, dans cette population, est de 300,0 %.
- c) La létalité correspond au nombre de décès parmi les malades.
- d) La létalité informe sur la dynamique de la maladie plutôt que sur sa gravité.
- e) Le taux de reproduction R de cette épidémie correspond aux cas secondaires engendrés par un cas, et non à la létalité.

40. Dans un département de 860 000 habitants, on dénombre 7 310 décès sur l'année.

- a) Le taux brut de mortalité de ce département est de 8,5 ‰.
- b) Le taux brut de mortalité de ce département est de 85,0 ‰.
- c) Le taux brut de mortalité se calcule en divisant le nombre de décès par la population.
- d) Le taux brut de mortalité se calcule en divisant le nombre de décès par le nombre de naissances vivantes.
- e) Comparé au taux brut de mortalité national (9,4 ‰ en 2023 et 2024), le taux de ce département est plus faible.

Série 3 — Questions 41 à 60

41. Concernant les différentes définitions de la santé et de sa promotion :

- a) Selon Blum, la santé consiste notamment à se comporter d'une façon qui permette la survie de l'espèce ainsi que l'accomplissement personnel ou le contentement de l'individu.
- b) Selon le Petit Robert, la santé est un bon état physiologique, un fonctionnement régulier et harmonieux de l'organisme humain pendant une période appréciable.
- c) Selon la Conférence d'Ottawa (1986), la promotion de la santé est le processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et de l'améliorer.
- d) Selon Steichen, la santé correspond à la normalité avec ses caractéristiques.
- e) D'un point de vue physiologique, la santé ne peut être définie par aucune norme du fonctionnement physique ou biologique.

42. Concernant la mortalité infantile et l'indice synthétique de fécondité :

- a) L'indice synthétique de fécondité (ISF) désigne le nombre d'enfants par femme, et son seuil de remplacement est de 2,1.
- b) Si l'ISF est inférieur au seuil de remplacement, une diminution de la population à long terme est possible, sans apport migratoire.
- c) Entre 2009 et 2023, la population française a diminué alors que l'indice synthétique de fécondité a augmenté.
- d) La portion de population se trouvant en très bonne santé augmente continûment avec l'âge.
- e) Selon l'enquête Insee 2002-2003, les femmes se trouvent plus souvent en très bonne santé que les hommes.

43. Concernant les définitions de la santé :

- a) Selon le Petit Robert, la santé est un bon état physiologique, un fonctionnement régulier et harmonieux de l'organisme humain pendant une période appréciable.
- b) Selon le chirurgien René Leriche (1936), « la santé c'est la vie dans le bruit des organes ».
- c) Selon l'OMS, la santé se définit exclusivement par l'absence de maladie ou d'infirmité.
- d) Selon l'OMS, la santé est une ressource pour chaque jour de la vie, et non une finalité de la vie.
- e) Dans le cadre de la santé positive, l'empowerment désigne l'accroissement de l'efficacité individuelle et des appuis sociaux.

44. Concernant les indicateurs de santé :

- a) Les seuls types d'indicateurs de santé reconnus par le cours sont la mortalité et la morbidité.
- b) Un indicateur de santé est un instrument de mesure grâce auquel des ensembles d'informations ou de données vont être agrégés, simplifiés ou résumés.
- c) Les indicateurs de santé sont des outils de décision et d'intervention pour les gouvernements, les agences de santé publique et les organisations médicales.
- d) La fiabilité (ou reproductibilité) fait partie des propriétés des indicateurs de santé.
- e) La complexité d'usage est présentée comme une propriété recherchée des indicateurs de santé.

45. Concernant les causes de mortalité en France :

- a) À partir de 65 ans, les décès sont considérés comme naturels et liés au vieillissement.
- b) En 2022, les tumeurs représentaient environ 27 % des décès en France et étaient la première cause de mortalité chez les hommes.
- c) En France, le nombre de naissances a toujours dépassé le nombre de décès depuis la Seconde Guerre mondiale, y compris en 2025.
- d) En France, on compte 600 000 à 650 000 décès par an, avec 646 000 décès en 2024 (augmentation de 6 700 par rapport à 2023).
- e) La mortalité toutes causes des hommes est plus importante que celle des femmes, pour toutes les classes d'âge.

46. Concernant la complémentarité entre médecine clinique et santé publique :

- a) Contrairement à la médecine clinique, la santé publique s'intéresse à la population, à des groupes de personnes.
- b) La médecine clinique traite la maladie, alors que la santé publique traite de la santé.
- c) La médecine clinique prend en charge une personne, ce que le cours nomme un « colloque singulier ».
- d) Les maladies d'importation et la réémergence de maladies sont citées comme des conséquences de la mondialisation.
- e) Parmi les crises sanitaires passées, le cours ne cite aucun exemple antérieur au Covid (2020).

47. Dans un département de 540 000 habitants, on dénombre 4 320 décès sur l'année.

- a) Le taux brut de mortalité de ce département est de 8,0 ‰.
- b) Le taux brut de mortalité de ce département est de 80,0 ‰.
- c) Le taux brut de mortalité se calcule en divisant le nombre de décès par la population.
- d) Le taux brut de mortalité se calcule en divisant le nombre de décès par le nombre de naissances vivantes.
- e) Comparé au taux brut de mortalité national (9,4 ‰ en 2023 et 2024), le taux de ce département est plus faible.

48. Dans une agglomération, on recense 610 cas d'une maladie chronique au 1er janvier de l'année (nombre de cas à cette date), puis 175 nouveaux cas sont diagnostiqués au cours de cette même année.

- a) Le nombre de 610 cas recensés au 1er janvier correspond à la prévalence.
- b) Le nombre de 610 cas recensés au 1er janvier correspond à l'incidence.
- c) Le nombre de 175 nouveaux cas diagnostiqués dans l'année correspond à l'incidence.
- d) Le nombre de 175 nouveaux cas diagnostiqués dans l'année correspond à la létalité.
- e) L'incidence de cette maladie permet notamment de savoir s'il y a épidémie ou non.

49. Concernant les causes de mortalité en France :

- a) En 2022, les tumeurs représentaient environ 27 % des décès en France et étaient la première cause de mortalité chez les femmes.
- b) Entre 1980 et 2004, les décès liés aux maladies cardiovasculaires ont fortement augmenté, malgré le développement de nouvelles thérapeutiques.
- c) En 2023, le nombre de décès en France a diminué de 5,3 % par rapport à l'année précédente.
- d) La mortalité toutes causes des femmes est plus importante que celle des hommes, sauf après 65 ans.
- e) Pour la première fois en 2025, le nombre de décès en France a dépassé le nombre de naissances, une inversion non observée depuis la guerre.

50. Dans un établissement scolaire, on recense 95 cas d'une maladie chronique au 1er janvier de l'année (nombre de cas à cette date), puis 31 nouveaux cas sont diagnostiqués au cours de cette même année.

- a) Le nombre de 95 cas recensés au 1er janvier correspond à la prévalence.
- b) Le nombre de 95 cas recensés au 1er janvier correspond à l'incidence.
- c) Le nombre de 31 nouveaux cas diagnostiqués dans l'année correspond à l'incidence.
- d) Le nombre de 31 nouveaux cas diagnostiqués dans l'année correspond à la létalité.
- e) L'incidence de cette maladie permet notamment de savoir s'il y a épidémie ou non.

51. Dans un département de 1 780 000 habitants, on dénombre 19 580 décès sur l'année.

- a) Le taux brut de mortalité de ce département est de 11,0 ‰.
- b) Le taux brut de mortalité de ce département est de 110,0 ‰.
- c) Le taux brut de mortalité se calcule en divisant le nombre de décès par la population.
- d) Le taux brut de mortalité se calcule en divisant le nombre de décès par le nombre de naissances vivantes.
- e) Comparé au taux brut de mortalité national (9,4 ‰ en 2023 et 2024), le taux de ce département est plus élevé.

52. Dans un département de 3 400 000 habitants, on dénombre 37 400 décès sur l'année.

- a) Le taux brut de mortalité de ce département est de 11,0 ‰.
- b) Le taux brut de mortalité de ce département est de 110,0 ‰.
- c) Le taux brut de mortalité se calcule en divisant le nombre de décès par la population.
- d) Le taux brut de mortalité se calcule en divisant le nombre de décès par le nombre de naissances vivantes.
- e) Comparé au taux brut de mortalité national (9,4 ‰ en 2023 et 2024), le taux de ce département est plus élevé.

53. Dans un service hospitalier, on recense 78 cas d'une maladie chronique au 1er janvier de l'année (nombre de cas à cette date), puis 22 nouveaux cas sont diagnostiqués au cours de cette même année.

- a) Le nombre de 78 cas recensés au 1er janvier correspond à la prévalence.
- b) Le nombre de 78 cas recensés au 1er janvier correspond à l'incidence.
- c) Le nombre de 22 nouveaux cas diagnostiqués dans l'année correspond à l'incidence.
- d) Le nombre de 22 nouveaux cas diagnostiqués dans l'année correspond à la létalité.
- e) L'incidence de cette maladie permet notamment de savoir s'il y a épidémie ou non.

54. Concernant la complémentarité entre médecine clinique et santé publique :

- a) Le terme « colloque singulier » désigne, dans le cours, l'approche de la santé publique par populations.
- b) Les indicateurs de santé sont présentés comme une conséquence de la mondialisation, au même titre que les maladies d'importation.
- c) Les maladies d'importation sont présentées comme sans lien avec le phénomène de mondialisation.
- d) La médecine clinique traite la maladie, alors que la santé publique traite de la santé.
- e) Contrairement à la santé publique, la médecine clinique s'intéresse en priorité à des groupes de personnes plutôt qu'à un patient individuel.

55. Concernant l'espérance de vie :

- a) En 2024, l'espérance de vie féminine en France (85,8 ans) était supérieure à celle de l'Allemagne, mais inférieure à celle de l'Espagne.
- b) En France en 2023, l'espérance de vie à la naissance était identique pour les hommes et les femmes, à 82,8 ans.
- c) L'écart d'espérance de vie entre hommes et femmes s'est progressivement réduit, passant de 7,8 ans en 1997 à 5,9 ans en 2022.
- d) L'espérance de vie à 35 ans est identique pour les hommes cadres et les hommes ouvriers, à 40 ans.
- e) En France, l'espérance de vie est uniforme sur l'ensemble du territoire, sans disparité régionale.

56. Concernant la mortalité en France :

- a) À partir de 65 ans, les décès sont considérés comme naturels et liés au vieillissement.
- b) En France, le nombre de naissances a toujours dépassé le nombre de décès depuis la Seconde Guerre mondiale, y compris en 2025.
- c) En France, on compte 600 000 à 650 000 décès par an, avec 600 000 décès en 2024 (diminution par rapport à 2023).
- d) Le taux de mortalité infantile en France est en diminution constante depuis 2018.
- e) En 2022, le nombre de décès en France a augmenté, notamment en lien avec le Covid, la grippe et la canicule.

57. Concernant la définition de la santé selon l'OMS et son évolution :

- a) Selon la Conférence d'Ottawa (1986), la promotion de la santé est le processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et de l'améliorer.
- b) Le Dry January et le mois sans tabac sont cités comme exemples de mesures de dépistage obligatoire.
- c) Selon le microbiologiste R. Dubos, la santé est un état physique et mental relativement exempt de gêne et de souffrance.
- d) Selon la Charte d'Ottawa, la santé est perçue comme une ressource de la vie quotidienne, et non comme le but de la vie.
- e) Selon Canguilhem, « la santé a remplacé le salut » et être en bonne santé est « un luxe biologique ».

58. Concernant la définition de la santé selon l'OMS et son évolution :

- a) Selon le chirurgien René Leriche (1936), « la santé c'est la vie dans le bruit des organes ».
- b) Le concept de santé positive met l'accent sur l'hypothèse d'un développement progressif de la maladie en étapes.
- c) Selon la Conférence d'Ottawa (1986), la promotion de la santé désigne exclusivement les campagnes de communication gouvernementales sur la santé.
- d) Selon Cotton (1982), la vie peut être considérée comme un rythme continu d'interactions et un état d'équilibre instable.
- e) Selon Steichen, la santé correspond à l'absence totale de toute variabilité individuelle.

59. Concernant la mortalité en France :

- a) Avant 65 ans, les décès sont systématiquement considérés comme naturels et liés au vieillissement.
- b) Le taux de mortalité infantile en France est en augmentation, passant de 3,6 ‰ en 2018 à 4,1 ‰ en 2024.
- c) Le taux de mortalité infantile se calcule en divisant le nombre de décès avant l'âge de 1 an par le nombre de naissances vivantes, et s'élevait à 4,1 ‰ en France en 2024.
- d) En 2000, les maladies cardiovasculaires étaient la 1^{ère} cause de décès et les tumeurs la 2^e ; en 2008, ce rang s'est inversé.
- e) En France, on compte 600 000 à 650 000 décès par an, avec 600 000 décès en 2024 (diminution par rapport à 2023).

60. Concernant les registres des cancers :

- a) La population de référence des registres des cancers est le plus souvent celle du département.
- b) Le CépiDc est un registre exclusivement dédié aux cancers colorectaux.
- c) Les informations des registres des cancers proviennent des anatomo-pathologistes, des biologistes et des cliniciens.
- d) Le big data en santé se caractérise par une explosion quantitative des données numériques et une haute technicité.
- e) Les MDO et les données de l'Insee/INED sont présentées comme des sources exclusivement utilisées en dehors de la France.

Série 4 — Questions 61 à 80

61. Concernant les indicateurs de santé :

- a) Les indicateurs de santé sont réservés à l'usage exclusif des cliniciens en cabinet privé.
- b) La disponibilité, la simplicité à l'usage et l'exactitude font partie des propriétés des indicateurs de santé.
- c) Un indicateur de santé est un instrument de mesure grâce auquel des ensembles d'informations ou de données vont être agrégés, simplifiés ou résumés.
- d) La fiabilité (ou reproductibilité) est présentée comme une propriété exclusive des seuls indicateurs de mortalité.
- e) Les seuls types d'indicateurs de santé reconnus par le cours sont la mortalité et la morbidité.

62. Concernant les missions et la définition de la santé publique :

- a) Dans la règle des 5P, la Prévision vise à surveiller les maladies et les risques pour la santé.
- b) Dans la règle des 5P, la Prévention vise à éviter la survenue de maladies, par exemple par la vaccination ou le dépistage.
- c) Selon l'OMS (1952), organiser des services médicaux et infirmiers en vue du diagnostic précoce et du traitement préventif des maladies fait partie de l'action collective concertée.
- d) Selon l'OMS (1952), l'objet final de la santé publique est de réduire les dépenses de l'État en matière de santé.
- e) La règle des 5P regroupe la Protection, la Prévention, la Promotion, la Prévision et la Provision.

63. Concernant l'histoire et la structuration de la santé publique :

- a) L'épidémie de peste noire a débuté en 1347 à Marseille et a causé 30 à 50 % de décès en Europe.
- b) La loi relative à la protection de la santé publique date de 1952, année de la définition de l'OMS.
- c) Louis Pasteur est associé exclusivement à la création des hôpitaux au Moyen Âge.
- d) Le Serment d'Hippocrate pose la déontologie de la pratique médicale, avec notamment des soins gratuits à l'indigent.
- e) Le courant hygiéniste (19e-début 20e siècle) correspond à l'émergence de l'épidémiologie, de l'hygiène et de la prévention.

64. Dans une région, on recense 520 cas d'une maladie chronique au 1er janvier de l'année (nombre de cas à cette date), puis 140 nouveaux cas sont diagnostiqués au cours de cette même année.

- a) Le nombre de 520 cas recensés au 1er janvier correspond à la prévalence.
- b) Le nombre de 520 cas recensés au 1er janvier correspond à l'incidence.
- c) Le nombre de 140 nouveaux cas diagnostiqués dans l'année correspond à l'incidence.
- d) Le nombre de 140 nouveaux cas diagnostiqués dans l'année correspond à la létalité.
- e) L'incidence de cette maladie permet notamment de savoir s'il y a épidémie ou non.

65. Concernant la règle des 5P et la santé publique :

- a) En tant que discipline autonome, la santé publique s'occupe exclusivement de l'état de santé individuel d'un patient donné.
- b) Selon l'OMS (1952), l'objet final de la santé publique est de permettre à chaque individu de jouir de son droit inné à la santé et à la longévité.
- c) La règle des 5P regroupe la Prévention, la Protection, la Population, la Pathologie et la Provision.
- d) Selon l'OMS (1952), organiser des services médicaux et infirmiers en vue du diagnostic précoce et du traitement préventif des maladies fait partie de l'action collective concertée.
- e) Selon l'OMS (1952), la santé publique repose exclusivement sur l'action individuelle de chaque patient, sans dimension collective.

66. Concernant la définition de la santé selon l'OMS et son évolution :

- a) Le Dry January et le mois sans tabac en novembre sont cités comme exemples de campagnes de promotion de la santé.
- b) Selon le sociologue R. Bastide, l'homme sain est celui qui est capable de riposter à un monde complexe et mouvant.
- c) Selon le Petit Robert, la santé est un bon état physiologique, un fonctionnement régulier et harmonieux de l'organisme humain pendant une période appréciable.
- d) La santé positive privilégie des stratégies ciblées sur un déterminant unique, à l'exclusion de toute combinaison.
- e) Selon le microbiologiste R. Dubos, la santé se définit uniquement par des critères mentaux, indépendamment de l'état physique.

67. Concernant les causes de mortalité en France :

- a) Le taux de mortalité infantile en France est en augmentation, passant de 3,6 ‰ en 2018 à 4,1 ‰ en 2024.
- b) Entre 1980 et 2004, les décès liés aux maladies tumorales et aux cancers ont diminué aussi fortement que ceux liés aux maladies cardiovasculaires.
- c) La mortalité toutes causes des femmes est plus importante que celle des hommes, sauf après 65 ans.
- d) Le taux brut de mortalité se calcule en divisant le nombre de décès par le nombre de naissances vivantes.
- e) En 2023, le nombre de décès en France a augmenté de 5,3 % par rapport à l'année précédente.

68. Au cours d'une épidémie, 500 personnes ont été atteintes par une maladie donnée ; parmi elles, 25 en sont décédées.

- a) La létalité de cette maladie, dans cette population, est de 5,0 %.
- b) La létalité de cette maladie, dans cette population, est de 50,0 %.
- c) La létalité correspond au nombre de décès parmi les malades.
- d) La létalité informe sur la dynamique de la maladie plutôt que sur sa gravité.
- e) Le taux de reproduction R de cette épidémie correspond aux cas secondaires engendrés par un cas, et non à la létalité.

69. Concernant l'espérance de vie :

- a) L'espérance de vie désigne l'âge maximal théorique que peut atteindre un individu.
- b) En 2024, l'espérance de vie féminine en France était la plus élevée d'Europe, devant l'Espagne et l'Allemagne.
- c) L'espérance de vie n'a jamais connu de baisse brutale au cours du 20^e siècle, y compris pendant les grandes guerres.
- d) L'espérance de vie à 35 ans est de 44,5 ans pour les hommes cadres, contre 38 ans pour les hommes ouvriers.
- e) En France, l'espérance de vie est globalement plus faible dans le nord de la France et dans les territoires d'Outre-mer.

70. Au cours d'une épidémie, 620 personnes ont été atteintes par une maladie donnée ; parmi elles, 62 en sont décédées.

- a) La létalité de cette maladie, dans cette population, est de 10,0 %.
- b) La létalité de cette maladie, dans cette population, est de 100,0 %.
- c) La létalité correspond au nombre de décès parmi les malades.
- d) La létalité informe sur la dynamique de la maladie plutôt que sur sa gravité.
- e) Le taux de reproduction R de cette épidémie correspond aux cas secondaires engendrés par un cas, et non à la létalité.

71. Au cours d'une épidémie, 240 personnes ont été atteintes par une maladie donnée ; parmi elles, 36 en sont décédées.

- a) La létalité de cette maladie, dans cette population, est de 15,0 %.
- b) La létalité de cette maladie, dans cette population, est de 150,0 %.
- c) La létalité correspond au nombre de décès parmi les malades.
- d) La létalité informe sur la dynamique de la maladie plutôt que sur sa gravité.
- e) Le taux de reproduction R de cette épidémie correspond aux cas secondaires engendrés par un cas, et non à la létalité.

72. Concernant la morbidité et les indicateurs de morbidité :

- a) Selon l'enquête Insee 2002-2003, les hommes se trouvent plus souvent en très bonne santé que les femmes.
- b) La mortalité, en épidémiologie descriptive, correspond au nombre de décès, mesuré par des indicateurs de mortalité brute ou spécifique.
- c) Les 3 types de morbidité sont la morbidité aiguë, la morbidité chronique et la morbidité mixte.
- d) Comparés aux femmes, les hommes déclarent moins souffrir d'une maladie, alors qu'ils sont pourtant les plus atteints de maladies.
- e) L'incidence correspond au nombre de nouveaux cas sur une période de temps, et informe sur la dynamique de la maladie.

73. Concernant les registres des cancers :

- a) Il existe 25 registres des cancers en France, dont 14 registres généraux et 11 registres spécialisés.
- b) Les informations des registres des cancers proviennent des anatomo-pathologistes, des biologistes et des cliniciens.
- c) La population de référence des registres des cancers est le plus souvent celle du département.
- d) Le CépiDc est une source de données sur les causes de décès en France, en accès libre sur internet.
- e) Les maladies à déclaration obligatoire (MDO) et les données démographiques (Insee, INED) font partie des sources de données en santé publique en France.

74. Dans un département, on recense 1250 cas d'une maladie chronique au 1er janvier de l'année (nombre de cas à cette date), puis 310 nouveaux cas sont diagnostiqués au cours de cette même année.

- a) Le nombre de 1250 cas recensés au 1er janvier correspond à la prévalence.
- b) Le nombre de 1250 cas recensés au 1er janvier correspond à l'incidence.
- c) Le nombre de 310 nouveaux cas diagnostiqués dans l'année correspond à l'incidence.
- d) Le nombre de 310 nouveaux cas diagnostiqués dans l'année correspond à la létalité.
- e) L'incidence de cette maladie permet notamment de savoir s'il y a épidémie ou non.

75. Concernant la complémentarité entre médecine clinique et santé publique :

- a) La santé publique repose exclusivement sur des méthodes thérapeutiques individuelles, à l'exclusion de l'épidémiologie.
- b) Parmi les crises sanitaires passées justifiant de mesurer l'état de santé figurent l'amiante (1970), le sang contaminé (1983) et le Covid (2020).
- c) Les maladies d'importation sont présentées comme sans lien avec le phénomène de mondialisation.
- d) La médecine clinique et la santé publique ont exactement le même objet, la maladie.
- e) Les indicateurs de santé sont présentés comme une conséquence de la mondialisation, au même titre que les maladies d'importation.

76. Dans une région, on dénombre 150 000 naissances vivantes sur une année, parmi lesquelles 555 enfants sont décédés avant l'âge de 1 an.

- a) Le taux de mortalité infantile de cette région est de 3,7 ‰.
- b) Le taux de mortalité infantile de cette région est de 37,0 ‰.
- c) Le taux de mortalité infantile se calcule en rapportant le nombre de décès avant 1 an au nombre de naissances vivantes.
- d) Le taux de mortalité infantile se calcule en rapportant le nombre de décès avant 1 an à la population totale.
- e) Le taux national de mortalité infantile était de 4,1 ‰ en France en 2024.

77. Concernant l'histoire et la structuration de la santé publique :

- a) La vaccination contre la variole a été mise au point par Louis Pasteur en 1848, sur le principe de pasteurisation.
- b) La loi relative à la protection de la santé publique, en 1902, a introduit le concept de santé publique en France.
- c) Le Serment d'Hippocrate concerne exclusivement l'organisation administrative des hôpitaux modernes.
- d) Les hôtels-Dieu étaient des établissements créés au 19e siècle par l'État pour la recherche médicale.
- e) Le courant hygiéniste (19e-début 20e siècle) correspond à l'abandon des mesures d'hygiène au profit de traitements uniquement curatifs.

78. Concernant les sources de données en santé publique :

- a) L'Inserm ne figure pas parmi les sources de données citées par le cours pour les causes de décès.
- b) Les informations des registres des cancers proviennent exclusivement des déclarations spontanées des patients.
- c) Les maladies à déclaration obligatoire (MDO) et les données démographiques (Insee, INED) font partie des sources de données en santé publique en France.
- d) Le big data en santé se caractérise par une explosion quantitative des données numériques et une haute technicité.
- e) Le CépîDc est un registre exclusivement dédié aux cancers colorectaux.

79. Concernant la prévalence, l'incidence et la létalité :

- a) Comparés aux femmes, les hommes déclarent moins souffrir d'une maladie, alors qu'ils sont pourtant les plus atteints de maladies.
- b) La prévalence correspond au nombre de cas sur une période de temps ou à un moment donné, et reflète l'importance quantitative de la maladie.
- c) La morbidité fait référence exclusivement aux décès, sans lien avec les maladies.
- d) Les 3 types de morbidité sont la morbidité aiguë, la morbidité chronique et la morbidité mixte.
- e) La mortalité, et non l'incidence, est l'indicateur qui permet de savoir s'il y a épidémie ou non.

80. Concernant l'histoire et la structuration de la santé publique :

- a) L'épidémie de peste noire a débuté en 1347 à Marseille et a causé 30 à 50 % de décès en Europe.
- b) La vaccination contre la variole a été mise au point par Louis Pasteur en 1848, sur le principe de pasteurisation.
- c) Le Serment d'Hippocrate concerne exclusivement l'organisation administrative des hôpitaux modernes.
- d) Le courant hygiéniste (19e-début 20e siècle) correspond à l'émergence de l'épidémiologie, de l'hygiène et de la prévention.
- e) Louis Pasteur est associé exclusivement à la création des hôtels-Dieu au Moyen Âge.

Série 5 — Questions 81 à 100

81. Au cours d'une épidémie, 800 personnes ont été atteintes par une maladie donnée ; parmi elles, 40 en sont décédées.

- a) La létalité de cette maladie, dans cette population, est de 5,0 %.
- b) La létalité de cette maladie, dans cette population, est de 50,0 %.
- c) La létalité correspond au nombre de décès parmi les malades.
- d) La létalité informe sur la dynamique de la maladie plutôt que sur sa gravité.
- e) Le taux de reproduction R de cette épidémie correspond aux cas secondaires engendrés par un cas, et non à la létalité.

82. Dans une région, on dénombre 340 000 naissances vivantes sur une année, parmi lesquelles 1 190 enfants sont décédés avant l'âge de 1 an.

- a) Le taux de mortalité infantile de cette région est de 3,5 ‰.
- b) Le taux de mortalité infantile de cette région est de 35,0 ‰.
- c) Le taux de mortalité infantile se calcule en rapportant le nombre de décès avant 1 an au nombre de naissances vivantes.
- d) Le taux de mortalité infantile se calcule en rapportant le nombre de décès avant 1 an à la population totale.
- e) Le taux national de mortalité infantile était de 4,1 ‰ en France en 2024.

83. Au cours d'une épidémie, 1000 personnes ont été atteintes par une maladie donnée ; parmi elles, 30 en sont décédées.

- a) La létalité de cette maladie, dans cette population, est de 3,0 %.
- b) La létalité de cette maladie, dans cette population, est de 30,0 %.
- c) La létalité correspond au nombre de décès parmi les malades.
- d) La létalité informe sur la dynamique de la maladie plutôt que sur sa gravité.
- e) Le taux de reproduction R de cette épidémie correspond aux cas secondaires engendrés par un cas, et non à la létalité.

84. Concernant la prévalence, l'incidence et la létalité :

- a) Selon l'enquête Insee 2002-2003, les femmes se trouvent plus souvent en très bonne santé que les hommes.
- b) La létalité correspond au nombre de décès parmi les malades, et informe sur la gravité de la maladie.
- c) La prévalence correspond exclusivement au nombre de nouveaux cas sur une période de temps.
- d) L'incidence permet notamment de savoir s'il y a épidémie ou non.
- e) Comparés aux femmes, les hommes déclarent moins souffrir d'une maladie, alors qu'ils sont pourtant les plus atteints de maladies.

85. Concernant la mortalité en France :

- a) En France, on compte 600 000 à 650 000 décès par an, avec 646 000 décès en 2024 (augmentation de 6 700 par rapport à 2023).
- b) Entre 1980 et 2004, les décès liés aux maladies tumorales et aux cancers ont diminué aussi fortement que ceux liés aux maladies cardiovasculaires.
- c) Le taux brut de mortalité se calcule en divisant le nombre de décès par le nombre de naissances vivantes.
- d) En 2022, les maladies cardiovasculaires représentaient environ 24 % des décès en France et étaient la première cause de mortalité chez les hommes.
- e) En 2022, le nombre de décès en France a fortement diminué par rapport aux années précédentes, sans lien avec des causes sanitaires particulières.

86. Dans une région, on dénombre 200 000 naissances vivantes sur une année, parmi lesquelles 780 enfants sont décédés avant l'âge de 1 an.

- a) Le taux de mortalité infantile de cette région est de 3,9 ‰.
- b) Le taux de mortalité infantile de cette région est de 39,0 ‰.
- c) Le taux de mortalité infantile se calcule en rapportant le nombre de décès avant 1 an au nombre de naissances vivantes.
- d) Le taux de mortalité infantile se calcule en rapportant le nombre de décès avant 1 an à la population totale.
- e) Le taux national de mortalité infantile était de 4,1 ‰ en France en 2024.

87. Concernant les indicateurs de santé :

- a) Les seuls types d'indicateurs de santé reconnus par le cours sont la mortalité et la morbidité.
- b) La fiabilité (ou reproductibilité) fait partie des propriétés des indicateurs de santé.
- c) La complexité d'usage est présentée comme une propriété recherchée des indicateurs de santé.
- d) Les indicateurs de santé fournissent des éléments indispensables à la connaissance de l'importance des problèmes de santé, à la prise de décision et à l'orientation de la recherche étiologique.
- e) Un indicateur de santé est une donnée brute individuelle, non agrégée, propre à un seul patient.

88. Dans une région, on dénombre 630 000 naissances vivantes sur une année, parmi lesquelles 2 772 enfants sont décédés avant l'âge de 1 an.

- a) Le taux de mortalité infantile de cette région est de 4,4 ‰.
- b) Le taux de mortalité infantile de cette région est de 44,0 ‰.
- c) Le taux de mortalité infantile se calcule en rapportant le nombre de décès avant 1 an au nombre de naissances vivantes.
- d) Le taux de mortalité infantile se calcule en rapportant le nombre de décès avant 1 an à la population totale.
- e) Le taux national de mortalité infantile était de 4,1 ‰ en France en 2024.

89. Concernant les définitions de la santé :

- a) Selon le chirurgien René Leriche (1936), « la santé c'est la vie dans le bruit des organes ».
- b) Selon l'OMS, la santé est la finalité ultime de la vie, un but à atteindre et non une ressource.
- c) Selon Canguilhem, la notion de santé n'a jamais eu de rapport avec la notion religieuse de salut.
- d) Selon Steichen, la santé correspond à l'absence totale de toute variabilité individuelle.
- e) Selon l'OMS, la santé se définit exclusivement par l'absence de maladie ou d'infirmité.

90. Concernant l'histoire et la structuration de la santé publique :

- a) Le courant hygiéniste (19e-début 20e siècle) correspond à l'émergence de l'épidémiologie, de l'hygiène et de la prévention.
- b) La loi relative à la protection de la santé publique date de 1952, année de la définition de l'OMS.
- c) Le Serment d'Hippocrate pose la déontologie de la pratique médicale, avec notamment des soins gratuits à l'indigent.
- d) L'épidémie de peste noire a débuté en 1347 à Marseille et a causé 30 à 50 % de décès en Europe.
- e) La vaccination contre la variole a été mise au point par Edward Jenner en 1796, sur le principe d'inoculation.

91. Concernant les sources de données en santé publique :

- a) Le CépiDc est une source de données sur les causes de décès en France, en accès libre sur internet.
- b) Le big data en santé se caractérise par une diminution du volume de données disponibles.
- c) Il existe 25 registres des cancers en France, dont 14 registres généraux et 11 registres spécialisés.
- d) Les informations des registres des cancers proviennent des anatomo-pathologistes, des biologistes et des cliniciens.
- e) La population de référence des registres des cancers est le plus souvent celle du département.

92. Concernant la règle des 5P et la santé publique :

- a) Selon l'OMS (2002), la santé publique se limite aux efforts d'institutions privées à but lucratif.
- b) En tant que discipline autonome, la santé publique s'occupe exclusivement de l'état de santé individuel d'un patient donné.
- c) Selon l'OMS (1952), l'objet final de la santé publique est de permettre à chaque individu de jouir de son droit inné à la santé et à la longévité.
- d) Selon l'OMS (1952), organiser des services médicaux et infirmiers en vue du diagnostic précoce et du traitement préventif des maladies fait partie de l'action collective concertée.
- e) Dans la règle des 5P, la Prévention vise à enrayer la propagation de maladies déjà présentes, par la gestion des urgences sanitaires.

93. Concernant la complémentarité entre médecine clinique et santé publique :

- a) La médecine clinique prend en charge une personne, ce que le cours nomme un « colloque singulier ».
- b) Parmi les crises sanitaires passées justifiant de mesurer l'état de santé figurent l'amiante (1970), le sang contaminé (1983) et le Covid (2020).
- c) Les indicateurs de santé sont présentés comme le moyen utilisé pour mesurer et observer l'état de santé.
- d) Contrairement à la santé publique, la médecine clinique s'intéresse en priorité à des groupes de personnes plutôt qu'à un patient individuel.
- e) Selon C. Everett Koop, les soins de santé (health care) sont vitaux à tous, tout le temps, alors que la santé publique ne l'est qu'occasionnellement.

94. En 2023 en France, l'espérance de vie à la naissance était de 80,0 ans pour les hommes et de 85,7 ans pour les femmes.

- a) L'écart d'espérance de vie entre les sexes, en 2023, est de 5,7 ans.
- b) L'écart d'espérance de vie entre les sexes, en 2023, est de 7,7 ans.
- c) Cet écart s'est réduit par rapport à 1997, où il était de 7,8 ans.
- d) Cet écart s'est creusé par rapport à 1997, où il était de 7,8 ans.
- e) Cette réduction de l'écart s'explique notamment par des facteurs de risque désormais similaires entre hommes et femmes (alcool, tabac, sédentarité).

95. Concernant les causes de mortalité en France :

- a) Entre 1980 et 2004, les décès liés aux maladies tumorales et aux cancers sont restés d'une très grande stabilité.
- b) La mortalité toutes causes des hommes est plus importante que celle des femmes, pour toutes les classes d'âge.
- c) En 2022, le nombre de décès en France a fortement diminué par rapport aux années précédentes, sans lien avec des causes sanitaires particulières.
- d) En France, on compte 600 000 à 650 000 décès par an, avec 600 000 décès en 2024 (diminution par rapport à 2023).
- e) Le taux de mortalité infantile en France est en augmentation, passant de 3,6 ‰ en 2018 à 4,1 ‰ en 2024.

96. Concernant la complémentarité entre médecine clinique et santé publique :

- a) La santé publique repose exclusivement sur des méthodes thérapeutiques individuelles, à l'exclusion de l'épidémiologie.
- b) Selon C. Everett Koop, les soins de santé (health care) sont vitaux à tous, tout le temps, alors que la santé publique ne l'est qu'occasionnellement.
- c) La médecine clinique et la santé publique ont exactement le même objet, la maladie.
- d) Les maladies d'importation sont présentées comme sans lien avec le phénomène de mondialisation.
- e) Contrairement à la santé publique, la médecine clinique s'intéresse en priorité à des groupes de personnes plutôt qu'à un patient individuel.

97. Concernant la mortalité en France :

- a) Le taux de mortalité infantile se calcule en divisant le nombre de décès avant l'âge de 1 an par la population totale.
- b) En 2022, les tumeurs représentaient environ 27 % des décès en France et étaient la première cause de mortalité chez les hommes.
- c) Avant 65 ans, les décès sont systématiquement considérés comme naturels et liés au vieillissement.
- d) Entre 1980 et 2004, les décès liés aux maladies cardiovasculaires ont diminué, notamment grâce au développement de thérapeutiques et à l'installation de défibrillateurs.
- e) Le taux brut de mortalité se calcule en divisant le nombre de décès par le nombre de naissances vivantes.

98. Concernant la prévalence, l'incidence et la létalité :

- a) Les hommes déclarent davantage souffrir de maladies que les femmes, en cohérence avec une prévalence plus élevée chez eux.
- b) La morbidité fait référence exclusivement aux décès, sans lien avec les maladies.
- c) La mortalité, en épidémiologie descriptive, correspond au nombre de décès, mesuré par des indicateurs de mortalité brute ou spécifique.
- d) L'incidence permet notamment de savoir s'il y a épidémie ou non.
- e) L'incidence correspond au nombre de décès parmi les malades, et informe sur la gravité de la maladie.

99. Concernant la morbidité et les indicateurs de morbidité :

- a) La létalité correspond au nombre de cas à un moment donné, et informe sur l'importance quantitative de la maladie.
- b) La portion de population se trouvant en très bonne santé augmente continûment avec l'âge.
- c) La prévalence correspond exclusivement au nombre de nouveaux cas sur une période de temps.
- d) Selon l'enquête Insee 2002-2003, les femmes se trouvent plus souvent en très bonne santé que les hommes.
- e) Les 3 types de morbidité sont la morbidité aiguë, la morbidité chronique et la morbidité mixte.

100. Concernant la mortalité infantile et l'indice synthétique de fécondité :

- a) L'indice synthétique de fécondité (ISF) désigne le nombre d'enfants par femme, et son seuil de remplacement est de 2,1.
- b) Si l'ISF est inférieur au seuil de remplacement, une diminution de la population à long terme est possible, sans apport migratoire.
- c) Entre 2009 et 2023, la population française a augmenté (de 62,6 à 68,4 millions d'habitants) alors que l'indice synthétique de fécondité a diminué (de 2,0 à 1,68).
- d) La fiabilité (ou reproductibilité) est présentée comme une propriété exclusive des seuls indicateurs de mortalité.
- e) La population de référence des registres des cancers est le plus souvent celle du département.

Santé publique — Introduction à la santé publique

QRM d'entraînement — 100 questions, 5 séries de 20 — CORRECTION

Série 1 — Correction (Questions 1 à 20)

1. Concernant les différentes définitions de la santé et de sa promotion :

- a) Selon Blum, la santé consiste notamment à se comporter d'une façon qui permette la survie de l'espèce ainsi que l'accomplissement personnel ou le contentement de l'individu. — **VRAI**

Blum décrit deux volets : la capacité de l'organisme à maintenir un équilibre, et un comportement permettant la survie de l'espèce aussi bien que l'accomplissement personnel ou le contentement de l'individu. (cf. p.1)

- b) Selon le microbiologiste R. Dubos, la santé se définit uniquement par des critères mentaux, indépendamment de l'état physique. — **FAUX**

Dubos définit la santé comme un état physique ET mental relativement exempt de gêne et de souffrance, pas uniquement mental. (cf. p.1)

- c) Selon Steichen, la santé correspond à la normalité avec ses caractéristiques. — **VRAI**

La citation de Steichen indique que la santé « correspond à la normalité avec ses caractéristiques ». (cf. p.1)

- d) Selon la Conférence d'Ottawa (1986), la promotion de la santé désigne exclusivement les campagnes de communication gouvernementales sur la santé. — **FAUX**

La définition officielle de la Conférence d'Ottawa (1986) est le processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et de l'améliorer. (cf. p.2)

- e) Le Dry January et le mois sans tabac en novembre sont cités comme exemples de campagnes de promotion de la santé. — **VRAI**

Le cours cite ces deux campagnes parmi les exemples de campagnes de promotion de la santé, non comme des mesures de dépistage. (cf. p.2)

2. Concernant les sources de données en santé publique :

- a) Les informations des registres des cancers proviennent des anatomo-pathologistes, des biologistes et des cliniciens. — **VRAI**

Le cours cite trois sources professionnelles : anatomo-pathologistes, biologistes, cliniciens. (cf. p.9)

- b) Il existe 14 registres des cancers en France, tous généraux, sans registre spécialisé. — **FAUX**

Le cours indique 25 registres au total en France : 14 généraux et 11 spécialisés. (cf. p.9)

- c) Le big data en santé se caractérise par une diminution du volume de données disponibles. — **FAUX**

Le cours décrit au contraire une « explosion quantitative des données numériques ». (cf. p.8)

- d) Le CépiDc est un registre exclusivement dédié aux cancers colorectaux. — **FAUX**

Le CépiDc centralise les causes de décès (accès libre sur internet), pas spécifiquement les cancers colorectaux (ce sont les registres des cancers). (cf. p.8)

- e) Les maladies à déclaration obligatoire (MDO) et les données démographiques (Insee, INED) font partie des sources de données en santé publique en France. — **VRAI**

Le cours liste les MDO et les données démographiques (Insee, INED) parmi les différentes sources de données françaises. (cf. p.8)

3. Concernant l'espérance de vie :

a) En France, l'espérance de vie est uniforme sur l'ensemble du territoire, sans disparité régionale. — **FAUX**

Le cours mentionne des « disparités régionales marquées, avec une espérance de vie globalement plus faible dans le nord de la France et [les] territoires d'Outre-mer ». (cf. p.14)

b) L'écart d'espérance de vie entre hommes et femmes s'est progressivement réduit, passant de 7,8 ans en 1997 à 5,9 ans en 2022. — **VRAI**

Le cours décrit une réduction progressive de l'écart, de 7,8 ans (1997) à 5,9 ans (2022), et non un creusement. (cf. p.14)

c) L'espérance de vie désigne l'âge maximal théorique que peut atteindre un individu. — **FAUX**

La définition du cours est le « nombre moyen probable d'années à vivre », pas un âge maximal théorique. (cf. p.14)

d) En 2024, l'espérance de vie féminine en France était la plus élevée d'Europe, devant l'Espagne et l'Allemagne. — **FAUX**

Le cours situe la France devant l'Allemagne mais derrière l'Espagne pour l'espérance de vie féminine en 2024. (cf. p.14)

e) En France en 2023, l'espérance de vie à la naissance était identique pour les hommes et les femmes, à 82,8 ans. — **FAUX**

Le cours donne des valeurs distinctes : 80,0 ans pour les hommes, 85,7 ans pour les femmes en 2023. (cf. p.14)

4. Dans une région, on dénombre 280 000 naissances vivantes sur une année, parmi lesquelles 980 enfants sont décédés avant l'âge de 1 an.

a) Le taux de mortalité infantile de cette région est de 3,5 ‰. — **VRAI**

Taux de mortalité infantile = décès avant 1 an / naissances vivantes × 1000 = 980 / 280000 × 1000 = 3,5 ‰. (cf. p.12)

b) Le taux de mortalité infantile de cette région est de 35,0 ‰. — **FAUX**

Le taux exact est de 3,5 ‰ ; 35,0 ‰ correspond à une erreur d'un facteur 10. (cf. p.12)

c) Le taux de mortalité infantile se calcule en rapportant le nombre de décès avant 1 an au nombre de naissances vivantes. — **VRAI**

C'est la définition exacte donnée par le cours. (cf. p.12)

d) Le taux de mortalité infantile se calcule en rapportant le nombre de décès avant 1 an à la population totale. — **FAUX**

C'est le nombre de naissances vivantes qui sert de dénominateur, pas la population totale. (cf. p.12)

e) Le taux national de mortalité infantile était de 4,1 ‰ en France en 2024. — **VRAI**

Valeur donnée par le cours pour l'année 2024 en France. (cf. p.12)

5. Concernant l'histoire et la structuration de la santé publique :

a) La vaccination contre la variole a été mise au point par Louis Pasteur en 1848, sur le principe de pasteurisation. — **FAUX**

Le cours attribue la vaccination contre la variole (1796, principe d'inoculation) à Edward Jenner, distincte des travaux de Pasteur. (cf. p.4)

b) La loi relative à la protection de la santé publique, en 1902, a introduit le concept de santé publique en France. — **VRAI**

Le cours date cette loi de 1902, distincte de la définition de l'OMS qui date de 1952. (cf. p.4)

c) Les hôtels-Dieu étaient des établissements créés au 19e siècle par l'État pour la recherche médicale. — **FAUX**

Le cours situe la création des hôtels-Dieu au Moyen Âge, tenus par des ordres religieux. (cf. p.4)

d) Le courant hygiéniste (19e-début 20e siècle) correspond à l'abandon des mesures d'hygiène au profit de traitements uniquement curatifs. — **FAUX**

Le cours définit le courant hygiéniste comme l'émergence de l'épidémiologie, de l'hygiène et de la prévention. (cf. p.4)

e) L'épidémie de peste noire a débuté en 1796 à Paris et a causé moins de 5 % de décès en Europe. — **FAUX**

Le cours date la peste noire de 1347, à Marseille, avec 30-50 % de décès en Europe. (cf. p.4)

6. Concernant la morbidité et les indicateurs de morbidité :

a) Le taux de reproduction, noté R, correspond aux cas secondaires engendrés par un cas et informe sur la contagiosité de la maladie. — **VRAI**

Le nombre de décès parmi les malades correspond à la létalité, pas au taux de reproduction R qui informe sur la contagiosité. (cf. p.11)

b) La mortalité, et non l'incidence, est l'indicateur qui permet de savoir s'il y a épidémie ou non. — **FAUX**

Le cours associe explicitement l'incidence à la question « épidémie ou non ». (cf. p.11)

c) Selon l'enquête Insee 2002-2003, les hommes se trouvent plus souvent en très bonne santé que les femmes. — **VRAI**

Le cours indique 28,2 % des hommes contre 21,5 % des femmes en très bonne santé, donc un avantage masculin sur ce critère. (cf. p.10)

d) Les hommes déclarent davantage souffrir de maladies que les femmes, en cohérence avec une prévalence plus élevée chez eux. — **FAUX**

Le cours souligne un paradoxe : les hommes déclarent moins souffrir de maladies, bien qu'ils soient les plus atteints. (cf. p.10)

e) La morbidité fait référence exclusivement aux décès, sans lien avec les maladies. — **FAUX**

Le cours définit la morbidité comme faisant référence aux maladies et pathologies ; les décès relèvent de la mortalité. (cf. p.10)

7. Dans un département de 975 000 habitants, on dénombre 8 287 décès sur l'année.

a) Le taux brut de mortalité de ce département est de 8,5 ‰. — **VRAI**

Taux brut de mortalité = décès / population = 8287 / 975000 × 1000 = 8,5 ‰. (cf. p.12)

b) Le taux brut de mortalité de ce département est de 85,0 ‰. — **FAUX**

Le taux exact est de 8,5 ‰ ; 85,0 ‰ correspond à une erreur d'un facteur 10. (cf. p.12)

c) Le taux brut de mortalité se calcule en divisant le nombre de décès par la population. — **VRAI**

C'est la définition du cours : nombre de décès / population. (cf. p.12)

d) Le taux brut de mortalité se calcule en divisant le nombre de décès par le nombre de naissances vivantes. — **FAUX**

Ce calcul correspond au taux de mortalité infantile, pas au taux brut de mortalité. (cf. p.12)

e) Comparé au taux brut de mortalité national (9,4 ‰ en 2023 et 2024), le taux de ce département est plus faible. — **VRAI**

8,5 ‰ est plus faible que le taux national de 9,4 ‰. (cf. p.12)

8. Concernant les différentes définitions de la santé et de sa promotion :

a) Le concept de santé positive met l'accent sur l'hypothèse d'un développement progressif de la maladie en étapes. — **VRAI**

Le cours associe la santé positive à l'hypothèse d'un développement progressif de la maladie en étapes. (cf. p.2)

b) Selon la Charte d'Ottawa, la santé est perçue comme une ressource de la vie quotidienne, et non comme le but de la vie. — **VRAI**

Le cours précise que « la santé est donc perçue comme une ressource de la vie quotidienne et non comme le but de la vie ». (cf. p.2)

c) Selon l'OMS, la santé se définit exclusivement par l'absence de maladie ou d'infirmité. — **FAUX**

La définition de l'OMS précise explicitement que la santé « ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité ». (cf. p.2)

d) La frontière entre le normal et le pathologique varie avec l'âge, la culture et l'état de la science. — **VRAI**

Le cours indique explicitement trois facteurs de variabilité de cette frontière : l'âge, la culture, l'état de la science. (cf. p.2)

e) Selon Blum, la santé consiste notamment à se comporter d'une façon qui permette la survie de l'espèce ainsi que l'accomplissement personnel ou le contentement de l'individu. — **VRAI**

Blum décrit deux volets : la capacité de l'organisme à maintenir un équilibre, et un comportement permettant la survie de l'espèce aussi bien que l'accomplissement personnel ou le contentement de l'individu. (cf. p.1)

9. Concernant les missions et la définition de la santé publique :

a) Selon l'OMS (1952), organiser des services médicaux et infirmiers en vue du diagnostic précoce et du traitement préventif des maladies fait partie de l'action collective concertée. — **VRAI**

Le cours liste explicitement « organiser des services médicaux et infirmiers en vue du diagnostic précoce et du traitement préventif des maladies » parmi les actions visées. (cf. p.3)

b) En tant que discipline autonome, la santé publique s'occupe de l'état de santé d'une collectivité, d'un groupe ou d'un collectif. — **VRAI**

Le cours définit la santé publique comme s'occupant de la santé globale des populations, non d'un individu isolé. (cf. p.5)

c) Selon l'OMS (1952), la santé publique vise notamment à prévenir les maladies, prolonger la vie et améliorer la santé par le moyen d'une action collective concertée. — **VRAI**

La définition de l'OMS (1952) insiste sur une action collective concertée, et non sur la seule action individuelle. (cf. p.3)

d) Dans la règle des 5P, la Prévention vise à éviter la survenue de maladies, par exemple par la vaccination ou le dépistage. — **VRAI**

Éviter la survenue de maladies (vaccination, dépistage) correspond à la Prévention ; enrayer la propagation correspond à la Protection. (cf. p.5)

e) Selon l'OMS (2002), la santé publique est l'ensemble des efforts par des institutions publiques dans une société pour améliorer, promouvoir, protéger et restaurer la santé de la population. — **VRAI**

Le cours attribue cette définition (2002) à des « institutions publiques », par une action collective. (cf. p.5)

10. Concernant les définitions de la santé :

a) Selon le chirurgien René Leriche (1936), « la santé c'est la vie dans le bruit des organes ». — **FAUX**

La citation exacte de Leriche (1936) est : « la santé c'est la vie dans le silence des organes ». (cf. p.1)

b) Dans le cadre de la santé positive, l'empowerment désigne l'accroissement de l'efficacité individuelle et des appuis sociaux. — **VRAI**

Le cours définit l'empowerment comme un « accroissement de l'efficacité individuelle et des appuis sociaux ». (cf. p.2)

c) Selon Cotton (1982), la vie peut être considérée comme un rythme continu d'interactions et un état d'équilibre instable. — **VRAI**

Cotton décrit un « état d'équilibre instable » et un bien-être qui « n'est jamais qu'un état passager à reconquérir sans cesse ». (cf. p.1)

d) Selon l'OMS, la santé est la finalité ultime de la vie, un but à atteindre et non une ressource. — **FAUX**

Le cours précise que « la santé est une ressource pour chaque jour de la vie, et n'est pas une finalité de la vie ». (cf. p.2)

e) La santé positive privilégie des stratégies ciblées sur un déterminant unique, à l'exclusion de toute combinaison. — **FAUX**

Le cours mentionne l'« importance de stratégies larges, prenant en compte une combinaison de déterminants ». (cf. p.2)

11. Concernant l'histoire et la structuration de la santé publique :

a) Louis Pasteur est associé à l'hypothèse d'agents à l'origine des épidémies, à la pasteurisation et à l'asepsie chirurgicale. — **VRAI**

Le cours associe Pasteur à l'hypothèse des agents infectieux, la pasteurisation et l'asepsie chirurgicale, pas aux hôpitaux-Dieu (Moyen Âge). (cf. p.4)

b) Le courant hygiéniste (19e-début 20e siècle) correspond à l'émergence de l'épidémiologie, de l'hygiène et de la prévention. — **VRAI**

Le cours définit le courant hygiéniste comme l'émergence de l'épidémiologie, de l'hygiène et de la prévention. (cf. p.4)

c) L'épidémie de peste noire a débuté en 1347 à Marseille et a causé 30 à 50 % de décès en Europe. — **VRAI**

Le cours date la peste noire de 1347, à Marseille, avec 30-50 % de décès en Europe. (cf. p.4)

d) Le Serment d'Hippocrate concerne exclusivement l'organisation administrative des hôpitaux modernes. — **FAUX**

Le cours associe le Serment d'Hippocrate à la déontologie de la pratique médicale et aux soins gratuits à l'indigent. (cf. p.4)

e) Les hôpitaux-Dieu étaient des établissements créés au 19e siècle par l'État pour la recherche médicale. — **FAUX**

Le cours situe la création des hôpitaux-Dieu au Moyen Âge, tenus par des ordres religieux. (cf. p.4)

12. Concernant les indicateurs de santé :

- a) La fiabilité (ou reproductibilité) fait partie des propriétés des indicateurs de santé. — **VRAI**
La fiabilité/reproductibilité est listée comme une propriété générale des indicateurs de santé, sans restriction aux seuls indicateurs de mortalité. (cf. p.7)
- b) Les indicateurs de santé ne sont utiles qu'à la recherche étiologique, sans lien avec la prise de décision. — **FAUX**
Le cours cite trois apports indispensables des indicateurs de santé : connaissance des problèmes, prise de décision, orientation de la recherche étiologique. (cf. p.7)
- c) Les seuls types d'indicateurs de santé reconnus par le cours sont la mortalité et la morbidité. — **FAUX**
Le cours cite cinq types : mortalité, morbidité, facteurs de risque, handicap, démographiques (ces derniers parfois ajoutés). (cf. p.7)
- d) Les indicateurs de santé sont réservés à l'usage exclusif des cliniciens en cabinet privé. — **FAUX**
Le cours cite les gouvernements, les agences de santé publique et les organisations médicales comme utilisateurs des indicateurs. (cf. p.7)
- e) Un indicateur de santé est une donnée brute individuelle, non agrégée, propre à un seul patient. — **FAUX**
La définition du cours insiste sur l'agrégation, la simplification ou le résumé d'ensembles d'informations, pas sur une donnée individuelle brute. (cf. p.7)

13. Concernant les différentes définitions de la santé et de sa promotion :

- a) Selon Canguilhem, la santé est la marge de tolérance aux infidélités du milieu, le volant régulateur des possibilités de réactions. — **VRAI**
Canguilhem définit la santé comme la marge de tolérance aux infidélités du milieu et le volant régulateur des possibilités de réactions, donc une notion variable et non une valeur fixe. (cf. p.1)
- b) Selon le sociologue R. Bastide, l'homme sain est celui qui s'ajuste passivement à toute évolution du monde sans jamais le modifier. — **FAUX**
Bastide décrit l'homme sain comme celui qui s'ajuste moins au monde qu'il n'est capable de le modifier, donc un rôle actif et non passif. (cf. p.1)
- c) Le Dry January et le mois sans tabac en novembre sont cités comme exemples de campagnes de promotion de la santé. — **VRAI**
Le cours cite ces deux campagnes parmi les exemples de campagnes de promotion de la santé, non comme des mesures de dépistage. (cf. p.2)
- d) Selon l'OMS, la santé est uniquement un état de bien-être physique, sans dimension mentale ni sociale. — **FAUX**
La définition de l'OMS inclut trois dimensions : physique, mentale et sociale. (cf. p.2)
- e) Selon Canguilhem, « la santé a remplacé le salut » et être en bonne santé est « un luxe biologique ». — **VRAI**
Canguilhem écrit explicitement que « la santé a remplacé le salut » et qu'être en bonne santé « c'est un luxe biologique ». (cf. p.1)

14. Concernant les définitions de la santé :

- a) Selon Canguilhem, la santé est la marge de tolérance aux infidélités du milieu, le volant régulateur des possibilités de réactions. — **VRAI**
Canguilhem définit la santé comme la marge de tolérance aux infidélités du milieu et le volant régulateur des possibilités de réactions, donc une notion variable et non une valeur fixe. (cf. p.1)
- b) Selon le Petit Robert, la santé est un bon état physiologique, un fonctionnement régulier et harmonieux de l'organisme humain pendant une période appréciable. — **VRAI**
Le Petit Robert définit la santé comme un bon état physiologique et un fonctionnement régulier et harmonieux de l'organisme, et non par la seule absence de maladie. (cf. p.1)
- c) D'un point de vue physiologique, la santé ne peut être définie par aucune norme du fonctionnement physique ou biologique. — **FAUX**
Le point de vue physiologique définit la santé par des normes de poids, mesures et capacités (visuelle, auditive, respiratoire), donc par des normes du fonctionnement physique et biologique. (cf. p.1)
- d) Selon le chirurgien René Leriche (1936), « la santé c'est la vie dans le silence des organes ». — **VRAI**
La citation exacte de Leriche (1936) est : « la santé c'est la vie dans le silence des organes ». (cf. p.1)
- e) Selon l'OMS, la santé se définit exclusivement par l'absence de maladie ou d'infirmité. — **FAUX**
La définition de l'OMS précise explicitement que la santé « ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité ». (cf. p.2)

15. Dans une région, on dénombre 520 000 naissances vivantes sur une année, parmi lesquelles 2 236 enfants sont décédés avant l'âge de 1 an.

a) Le taux de mortalité infantile de cette région est de 4,3 ‰. — **VRAI**

Taux de mortalité infantile = décès avant 1 an / naissances vivantes × 1000 = 2236 / 520000 × 1000 = 4,3 ‰. (cf. p.12)

b) Le taux de mortalité infantile de cette région est de 43,0 ‰. — **FAUX**

Le taux exact est de 4,3 ‰ ; 43,0 ‰ correspond à une erreur d'un facteur 10. (cf. p.12)

c) Le taux de mortalité infantile se calcule en rapportant le nombre de décès avant 1 an au nombre de naissances vivantes. — **VRAI**

C'est la définition exacte donnée par le cours. (cf. p.12)

d) Le taux de mortalité infantile se calcule en rapportant le nombre de décès avant 1 an à la population totale. — **FAUX**

C'est le nombre de naissances vivantes qui sert de dénominateur, pas la population totale. (cf. p.12)

e) Le taux national de mortalité infantile était de 4,1 ‰ en France en 2024. — **VRAI**

Valeur donnée par le cours pour l'année 2024 en France. (cf. p.12)

16. Dans une région, on dénombre 410 000 naissances vivantes sur une année, parmi lesquelles 1 722 enfants sont décédés avant l'âge de 1 an.

a) Le taux de mortalité infantile de cette région est de 4,2 ‰. — **VRAI**

Taux de mortalité infantile = décès avant 1 an / naissances vivantes × 1000 = 1722 / 410000 × 1000 = 4,2 ‰. (cf. p.12)

b) Le taux de mortalité infantile de cette région est de 42,0 ‰. — **FAUX**

Le taux exact est de 4,2 ‰ ; 42,0 ‰ correspond à une erreur d'un facteur 10. (cf. p.12)

c) Le taux de mortalité infantile se calcule en rapportant le nombre de décès avant 1 an au nombre de naissances vivantes. — **VRAI**

C'est la définition exacte donnée par le cours. (cf. p.12)

d) Le taux de mortalité infantile se calcule en rapportant le nombre de décès avant 1 an à la population totale. — **FAUX**

C'est le nombre de naissances vivantes qui sert de dénominateur, pas la population totale. (cf. p.12)

e) Le taux national de mortalité infantile était de 4,1 ‰ en France en 2024. — **VRAI**

Valeur donnée par le cours pour l'année 2024 en France. (cf. p.12)

17. Concernant la morbidité et les indicateurs de morbidité :

a) La mortalité, en épidémiologie descriptive, correspond au nombre de décès, mesuré par des indicateurs de mortalité brute ou spécifique. — **VRAI**

Le nombre de nouveaux cas correspond à l'incidence, non à la mortalité qui correspond au nombre de décès. (cf. p.11)

b) La portion de population se trouvant en très bonne santé augmente continûment avec l'âge. — **FAUX**

Le cours décrit une diminution de la très bonne santé perçue avec l'augmentation de l'âge, et non une augmentation. (cf. p.10)

c) La létalité correspond au nombre de décès parmi les malades, et informe sur la gravité de la maladie. — **VRAI**

Le nombre de cas à un moment donné correspond à la prévalence, pas à la létalité qui mesure les décès parmi les malades. (cf. p.11)

d) Comparés aux femmes, les hommes déclarent moins souffrir d'une maladie, alors qu'ils sont pourtant les plus atteints de maladies. — **VRAI**

Le cours souligne un paradoxe : les hommes déclarent moins souffrir de maladies, bien qu'ils soient les plus atteints. (cf. p.10)

e) L'incidence correspond au nombre de décès parmi les malades, et informe sur la gravité de la maladie. — **FAUX**

Le nombre de décès parmi les malades correspond à la létalité (gravité), pas à l'incidence (dynamique/nouveaux cas). (cf. p.11)

18. Dans un pays fictif, l'indice synthétique de fécondité (ISF) est de 1,9, sans apport migratoire notable.

- a) Cet ISF est inférieur au seuil de remplacement de 2,1. — **VRAI**
1,9 est inférieur à 2,1, le seuil de remplacement des générations. (cf. p.15)
- b) Cet ISF est supérieur au seuil de remplacement de 2,1. — **FAUX**
1,9 est inférieur, et non supérieur, au seuil de remplacement de 2,1. (cf. p.15)
- c) Une diminution de la population à long terme est possible dans ce contexte, sans apport migratoire. — **VRAI**
Le cours indique qu'un ISF sous le seuil de remplacement rend possible une diminution de la population à long terme sans apport migratoire. (cf. p.15)
- d) Le remplacement des générations est garanti dans ce contexte, sans apport migratoire. — **FAUX**
Le remplacement des générations sans apport migratoire suppose un ISF au moins égal au seuil de 2,1, non atteint ici. (cf. p.15)
- e) L'indice synthétique de fécondité désigne le nombre d'enfants par femme. — **VRAI**
C'est la définition donnée par le cours, à distinguer du taux de fécondité. (cf. p.15)

19. Concernant la prévalence, l'incidence et la létalité :

- a) Les hommes déclarent davantage souffrir de maladies que les femmes, en cohérence avec une prévalence plus élevée chez eux. — **FAUX**
Le cours souligne un paradoxe : les hommes déclarent moins souffrir de maladies, bien qu'ils soient les plus atteints. (cf. p.10)
- b) Les 3 types de morbidité sont la morbidité ressentie, la morbidité diagnostiquée et la morbidité réelle. — **VRAI**
Le cours cite précisément : morbidité ressentie, morbidité diagnostiquée, morbidité réelle. (cf. p.10)
- c) La létalité correspond au nombre de cas à un moment donné, et informe sur l'importance quantitative de la maladie. — **FAUX**
Le nombre de cas à un moment donné correspond à la prévalence, pas à la létalité qui mesure les décès parmi les malades. (cf. p.11)
- d) La prévalence correspond exclusivement au nombre de nouveaux cas sur une période de temps. — **FAUX**
Le nombre de nouveaux cas correspond à l'incidence, non à la prévalence, qui reflète le nombre de cas total à un instant ou sur une période. (cf. p.11)
- e) L'incidence correspond au nombre de décès parmi les malades, et informe sur la gravité de la maladie. — **FAUX**
Le nombre de décès parmi les malades correspond à la létalité (gravité), pas à l'incidence (dynamique/nouveaux cas). (cf. p.11)

20. Dans un département de 690 000 habitants, on dénombre 5 520 décès sur l'année.

- a) Le taux brut de mortalité de ce département est de 8,0 ‰. — **VRAI**
Taux brut de mortalité = décès / population = 5520 / 690000 × 1000 = 8,0 ‰. (cf. p.12)
- b) Le taux brut de mortalité de ce département est de 80,0 ‰. — **FAUX**
Le taux exact est de 8,0 ‰ ; 80,0 ‰ correspond à une erreur d'un facteur 10. (cf. p.12)
- c) Le taux brut de mortalité se calcule en divisant le nombre de décès par la population. — **VRAI**
C'est la définition du cours : nombre de décès / population. (cf. p.12)
- d) Le taux brut de mortalité se calcule en divisant le nombre de décès par le nombre de naissances vivantes. — **FAUX**
Ce calcul correspond au taux de mortalité infantile, pas au taux brut de mortalité. (cf. p.12)
- e) Comparé au taux brut de mortalité national (9,4 ‰ en 2023 et 2024), le taux de ce département est plus faible. — **VRAI**
8,0 ‰ est plus faible que le taux national de 9,4 ‰. (cf. p.12)

Série 2 — Correction (Questions 21 à 40)

21. Concernant les indicateurs de santé :

- a) La fiabilité (ou reproductibilité) est présentée comme une propriété exclusive des seuls indicateurs de mortalité. — **FAUX**

La fiabilité/reproductibilité est listée comme une propriété générale des indicateurs de santé, sans restriction aux seuls indicateurs de mortalité. (cf. p.7)

- b) Un indicateur de santé est un instrument de mesure grâce auquel des ensembles d'informations ou de données vont être agrégés, simplifiés ou résumés. — **VRAI**

La définition du cours insiste sur l'agrégation, la simplification ou le résumé d'ensembles d'informations, pas sur une donnée individuelle brute. (cf. p.7)

- c) Les indicateurs de santé sont réservés à l'usage exclusif des cliniciens en cabinet privé. — **FAUX**

Le cours cite les gouvernements, les agences de santé publique et les organisations médicales comme utilisateurs des indicateurs. (cf. p.7)

- d) Les indicateurs de santé fournissent des éléments indispensables à la connaissance de l'importance des problèmes de santé, à la prise de décision et à l'orientation de la recherche étiologique. — **VRAI**

Le cours cite trois apports indispensables des indicateurs de santé : connaissance des problèmes, prise de décision, orientation de la recherche étiologique. (cf. p.7)

- e) Les seuls types d'indicateurs de santé reconnus par le cours sont la mortalité et la morbidité. — **FAUX**

Le cours cite cinq types : mortalité, morbidité, facteurs de risque, handicap, démographiques (ces derniers parfois ajoutés). (cf. p.7)

22. Concernant la règle des 5P et la santé publique :

- a) Dans la règle des 5P, la Prévision vise à surveiller les maladies et les risques pour la santé. — **VRAI**

Surveiller les maladies et les risques correspond à la Prévision ; donner des soins correspond à la Provision. (cf. p.5)

- b) La règle des 5P regroupe la Protection, la Prévention, la Promotion, la Prévision et la Provision. — **VRAI**

Les 5P du cours sont : Protection, Prévention, Promotion, Prévision, Provision. (cf. p.5)

- c) Selon l'OMS (1952), organiser des services médicaux et infirmiers en vue du diagnostic précoce et du traitement préventif des maladies fait partie de l'action collective concertée. — **VRAI**

Le cours liste explicitement « organiser des services médicaux et infirmiers en vue du diagnostic précoce et du traitement préventif des maladies » parmi les actions visées. (cf. p.3)

- d) Selon l'OMS (1952), la santé publique repose exclusivement sur l'action individuelle de chaque patient, sans dimension collective. — **FAUX**

La définition de l'OMS (1952) insiste sur une action collective concertée, et non sur la seule action individuelle. (cf. p.3)

- e) En tant que discipline autonome, la santé publique s'occupe de l'état de santé d'une collectivité, d'un groupe ou d'un collectif. — **VRAI**

Le cours définit la santé publique comme s'occupant de la santé globale des populations, non d'un individu isolé. (cf. p.5)

23. Dans un département de 4 120 000 habitants, on dénombre 41 200 décès sur l'année.

- a) Le taux brut de mortalité de ce département est de 10,0 ‰. — **VRAI**

Taux brut de mortalité = décès / population = 41200 / 4120000 × 1000 = 10,0 ‰. (cf. p.12)

- b) Le taux brut de mortalité de ce département est de 100,0 ‰. — **FAUX**

Le taux exact est de 10,0 ‰ ; 100,0 ‰ correspond à une erreur d'un facteur 10. (cf. p.12)

- c) Le taux brut de mortalité se calcule en divisant le nombre de décès par la population. — **VRAI**

C'est la définition du cours : nombre de décès / population. (cf. p.12)

- d) Le taux brut de mortalité se calcule en divisant le nombre de décès par le nombre de naissances vivantes. — **FAUX**

Ce calcul correspond au taux de mortalité infantile, pas au taux brut de mortalité. (cf. p.12)

- e) Comparé au taux brut de mortalité national (9,4 ‰ en 2023 et 2024), le taux de ce département est plus élevé. — **VRAI**

10,0 ‰ est plus élevé que le taux national de 9,4 ‰. (cf. p.12)

24. Concernant la définition de la santé selon l'OMS et son évolution :

a) Dans le cadre de la santé positive, l'empowerment désigne la diminution de l'autonomie individuelle au profit d'un contrôle institutionnel. — **FAUX**

Le cours définit l'empowerment comme un « accroissement de l'efficacité individuelle et des appuis sociaux ». (cf. p.2)

b) D'un point de vue physiologique, la santé correspond à des normes du fonctionnement physique et biologique (poids, mesures, capacités visuelle, auditive, respiratoire...). — **VRAI**

Le point de vue physiologique définit la santé par des normes de poids, mesures et capacités (visuelle, auditive, respiratoire), donc par des normes du fonctionnement physique et biologique. (cf. p.1)

c) Selon Canguilhem, la notion de santé n'a jamais eu de rapport avec la notion religieuse de salut. — **FAUX**

Canguilhem écrit explicitement que « la santé a remplacé le salut » et qu'être en bonne santé « c'est un luxe biologique ». (cf. p.1)

d) Selon le chirurgien René Leriche (1936), « la santé c'est la vie dans le silence des organes ». — **VRAI**

La citation exacte de Leriche (1936) est : « la santé c'est la vie dans le silence des organes ». (cf. p.1)

e) Selon l'OMS, la santé se définit exclusivement par l'absence de maladie ou d'infirmité. — **FAUX**

La définition de l'OMS précise explicitement que la santé « ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité ». (cf. p.2)

25. Concernant la mortalité en France :

a) À partir de 65 ans, les décès sont considérés comme naturels et liés au vieillissement. — **VRAI**

Le cours situe ce seuil à 65 ans ; avant cet âge, il évoque une capacité d'accompagner les gens pour qu'ils ne meurent pas, non une mortalité considérée comme naturelle. (cf. p.12)

b) Entre 1980 et 2004, les décès liés aux maladies tumorales et aux cancers ont diminué aussi fortement que ceux liés aux maladies cardiovasculaires. — **FAUX**

Le cours oppose la diminution des décès cardiovasculaires à la « très grande stabilité » des décès tumoraux/cancers. (cf. p.13)

c) En 2022, le nombre de décès en France a fortement diminué par rapport aux années précédentes, sans lien avec des causes sanitaires particulières. — **FAUX**

Le cours indique 670 000 décès en 2022, en augmentation, liée au Covid, à la grippe et à la canicule. (cf. p.12)

d) Pour la première fois en 2025, le nombre de décès en France a dépassé le nombre de naissances, une inversion non observée depuis la guerre. — **VRAI**

Le cours indique explicitement qu'en 2025, pour la première fois, le nombre de décès a dépassé le nombre de naissances, une inversion non observée depuis la guerre. (cf. p.12)

e) En France, on compte 600 000 à 650 000 décès par an, avec 600 000 décès en 2024 (diminution par rapport à 2023). — **FAUX**

Le cours indique précisément 646 000 décès en 2024, en augmentation de 6 700 par rapport à 2023 (639 300). (cf. p.12)

26. Concernant la complémentarité entre médecine clinique et santé publique :

a) La santé publique fait la promotion de la santé et prévient l'apparition des maladies, par l'épidémiologie, l'administration de la santé et la sociologie. — **VRAI**

Le tableau attribue les méthodes thérapeutiques à la médecine clinique, et l'épidémiologie/administration de la santé/sociologie à la santé publique. (cf. p.6)

b) Selon C. Everett Koop, les soins de santé (health care) sont vitaux à tous, tout le temps, alors que la santé publique ne l'est qu'occasionnellement. — **FAUX**

La citation de Koop inverse ces deux rôles : « health care is vital to all of us some of the time, but public health is vital to all of us all of the time ». (cf. p.6)

c) La médecine clinique prend en charge une personne, ce que le cours nomme un « colloque singulier ». — **VRAI**

Le « colloque singulier » désigne la prise en charge d'une personne par la médecine clinique, non l'approche par populations de la santé publique. (cf. p.6)

d) Les maladies d'importation et la réémergence de maladies sont citées comme des conséquences de la mondialisation. — **VRAI**

Le cours classe explicitement les maladies d'importation et la réémergence de maladies parmi les « conséquences de la mondialisation ». (cf. p.6)

e) Les indicateurs de santé sont présentés comme une conséquence de la mondialisation, au même titre que les maladies d'importation. — **FAUX**

Le cours distingue les « Raisons » (crises sanitaires, mondialisation, inégalités...) des « Moyens », qui sont les indicateurs de santé. (cf. p.6)

27. Concernant la mortalité en France :

a) Avant 65 ans, les décès sont systématiquement considérés comme naturels et liés au vieillissement.

— **FAUX**

Le cours situe ce seuil à 65 ans ; avant cet âge, il évoque une capacité d'accompagner les gens pour qu'ils ne meurent pas, non une mortalité considérée comme naturelle. (cf. p.12)

b) La mortalité toutes causes des femmes est plus importante que celle des hommes, sauf après 65 ans.

— **FAUX**

Le cours décrit une surmortalité masculine globale, pour toutes les classes d'âge, et non une surmortalité féminine. (cf. p.12)

c) En 2022, les tumeurs représentaient environ 27 % des décès en France et étaient la première cause de mortalité chez les hommes. — **VRAI**

Le cours précise que les tumeurs sont la 1ère cause de mortalité chez les hommes, alors que les maladies cardiovasculaires sont la 1ère cause chez les femmes. (cf. p.13)

d) Entre 1980 et 2004, les décès liés aux maladies tumorales et aux cancers sont restés d'une très grande stabilité. — **VRAI**

Le cours oppose la diminution des décès cardiovasculaires à la « très grande stabilité » des décès tumoraux/cancers. (cf. p.13)

e) Le taux de mortalité infantile en France est en augmentation, passant de 3,6 ‰ en 2018 à 4,1 ‰ en 2024. — **VRAI**

Le cours décrit une augmentation du taux de mortalité infantile, de 3,6 ‰ (2018) à 4,1 ‰ (2024). (cf. p.15)

28. Concernant les définitions de la santé :

a) Selon le microbiologiste R. Dubos, la santé est un état physique et mental relativement exempt de gêne et de souffrance. — **VRAI**

Dubos définit la santé comme un état physique ET mental relativement exempt de gêne et de souffrance, pas uniquement mental. (cf. p.1)

b) Selon l'OMS, la santé est la finalité ultime de la vie, un but à atteindre et non une ressource. — **FAUX**

Le cours précise que « la santé est une ressource pour chaque jour de la vie, et n'est pas une finalité de la vie ». (cf. p.2)

c) D'un point de vue physiologique, la santé ne peut être définie par aucune norme du fonctionnement physique ou biologique. — **FAUX**

Le point de vue physiologique définit la santé par des normes de poids, mesures et capacités (visuelle, auditive, respiratoire), donc par des normes du fonctionnement physique et biologique. (cf. p.1)

d) Selon la Conférence d'Ottawa (1986), la promotion de la santé est le processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et de l'améliorer. — **VRAI**

La définition officielle de la Conférence d'Ottawa (1986) est le processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et de l'améliorer. (cf. p.2)

e) Selon l'OMS, la santé est uniquement un état de bien-être physique, sans dimension mentale ni sociale. — **FAUX**

La définition de l'OMS inclut trois dimensions : physique, mentale et sociale. (cf. p.2)

29. Dans une commune, on recense 340 cas d'une maladie chronique au 1er janvier de l'année (nombre de cas à cette date), puis 95 nouveaux cas sont diagnostiqués au cours de cette même année.

a) Le nombre de 340 cas recensés au 1er janvier correspond à la prévalence. — **VRAI**

Le nombre de cas à un moment donné correspond à la prévalence. (cf. p.11)

b) Le nombre de 340 cas recensés au 1er janvier correspond à l'incidence. — **FAUX**

Le nombre de cas à un moment donné correspond à la prévalence, pas à l'incidence. (cf. p.11)

c) Le nombre de 95 nouveaux cas diagnostiqués dans l'année correspond à l'incidence. — **VRAI**

Le nombre de nouveaux cas sur une période correspond à l'incidence. (cf. p.11)

d) Le nombre de 95 nouveaux cas diagnostiqués dans l'année correspond à la létalité. — **FAUX**

La létalité correspond au nombre de décès parmi les malades, pas au nombre de nouveaux cas. (cf. p.11)

e) L'incidence de cette maladie permet notamment de savoir s'il y a épidémie ou non. — **VRAI**

Le cours associe explicitement l'incidence à la question de savoir s'il y a épidémie ou non. (cf. p.11)

30. Concernant les définitions de la santé :

a) D'un point de vue physiologique, la santé correspond à des normes du fonctionnement physique et biologique (poids, mesures, capacités visuelle, auditive, respiratoire...). — **VRAI**

Le point de vue physiologique définit la santé par des normes de poids, mesures et capacités (visuelle, auditive, respiratoire), donc par des normes du fonctionnement physique et biologique. (cf. p.1)

b) Selon Cotton (1982), la vie peut être considérée comme un rythme continu d'interactions et un état d'équilibre instable. — **VRAI**

Cotton décrit un « état d'équilibre instable » et un bien-être qui « n'est jamais qu'un état passager à reconquérir sans cesse ». (cf. p.1)

c) Selon l'OMS, la santé se définit exclusivement par l'absence de maladie ou d'infirmité. — **FAUX**

La définition de l'OMS précise explicitement que la santé « ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité ». (cf. p.2)

d) Selon Blum, la santé consiste notamment à se comporter d'une façon qui permette la survie de l'espèce ainsi que l'accomplissement personnel ou le contentement de l'individu. — **VRAI**

Blum décrit deux volets : la capacité de l'organisme à maintenir un équilibre, et un comportement permettant la survie de l'espèce aussi bien que l'accomplissement personnel ou le contentement de l'individu. (cf. p.1)

e) Selon la Charte d'Ottawa, la santé est perçue comme une ressource de la vie quotidienne, et non comme le but de la vie. — **VRAI**

Le cours précise que « la santé est donc perçue comme une ressource de la vie quotidienne et non comme le but de la vie ». (cf. p.2)

31. Concernant les différentes définitions de la santé et de sa promotion :

a) Selon l'OMS, la santé est la finalité ultime de la vie, un but à atteindre et non une ressource. — **FAUX**

Le cours précise que « la santé est une ressource pour chaque jour de la vie, et n'est pas une finalité de la vie ». (cf. p.2)

b) Selon Blum, la santé consiste exclusivement en la survie de l'espèce, sans lien avec l'accomplissement personnel de l'individu. — **FAUX**

Blum décrit deux volets : la capacité de l'organisme à maintenir un équilibre, et un comportement permettant la survie de l'espèce aussi bien que l'accomplissement personnel ou le contentement de l'individu. (cf. p.1)

c) La santé positive met l'accent sur l'importance de stratégies larges, prenant en compte une combinaison de déterminants. — **VRAI**

Le cours mentionne l'« importance de stratégies larges, prenant en compte une combinaison de déterminants ». (cf. p.2)

d) Selon le chirurgien René Leriche (1936), « la santé c'est la vie dans le bruit des organes ». — **FAUX**

La citation exacte de Leriche (1936) est : « la santé c'est la vie dans le silence des organes ». (cf. p.1)

e) Selon Canguilhem, la notion de santé n'a jamais eu de rapport avec la notion religieuse de salut. — **FAUX**

Canguilhem écrit explicitement que « la santé a remplacé le salut » et qu'être en bonne santé « c'est un luxe biologique ». (cf. p.1)

32. Concernant les missions et la définition de la santé publique :

a) Selon l'OMS (1952), la santé publique vise notamment à prévenir les maladies, prolonger la vie et améliorer la santé par le moyen d'une action collective concertée. — **VRAI**

La définition de l'OMS (1952) insiste sur une action collective concertée, et non sur la seule action individuelle. (cf. p.3)

b) Selon l'OMS (2002), la santé publique est l'ensemble des efforts par des institutions publiques dans une société pour améliorer, promouvoir, protéger et restaurer la santé de la population. — **VRAI**

Le cours attribue cette définition (2002) à des « institutions publiques », par une action collective. (cf. p.5)

c) Dans la règle des 5P, la Prévision vise à surveiller les maladies et les risques pour la santé. — **VRAI**

Surveiller les maladies et les risques correspond à la Prévision ; donner des soins correspond à la Provision. (cf. p.5)

d) Selon l'OMS (1952), l'organisation de services médicaux n'est pas mentionnée parmi les actions de santé publique. — **FAUX**

Le cours liste explicitement « organiser des services médicaux et infirmiers en vue du diagnostic précoce et du traitement préventif des maladies » parmi les actions visées. (cf. p.3)

e) Selon l'OMS (1952), l'objet final de la santé publique est de réduire les dépenses de l'État en matière de santé. — **FAUX**

Le cours précise que « l'objet final [est] de permettre à chaque individu de jouir de son droit inné à la santé et à la longévité ». (cf. p.3)

33. Dans un pays fictif, l'indice synthétique de fécondité (ISF) est de 1,6, sans apport migratoire notable.

- a) Cet ISF est inférieur au seuil de remplacement de 2,1. — **VRAI**
1,6 est inférieur à 2,1, le seuil de remplacement des générations. (cf. p.15)
- b) Cet ISF est supérieur au seuil de remplacement de 2,1. — **FAUX**
1,6 est inférieur, et non supérieur, au seuil de remplacement de 2,1. (cf. p.15)
- c) Une diminution de la population à long terme est possible dans ce contexte, sans apport migratoire. — **VRAI**
Le cours indique qu'un ISF sous le seuil de remplacement rend possible une diminution de la population à long terme sans apport migratoire. (cf. p.15)
- d) Le remplacement des générations est garanti dans ce contexte, sans apport migratoire. — **FAUX**
Le remplacement des générations sans apport migratoire suppose un ISF au moins égal au seuil de 2,1, non atteint ici. (cf. p.15)
- e) L'indice synthétique de fécondité désigne le nombre d'enfants par femme. — **VRAI**
C'est la définition donnée par le cours, à distinguer du taux de fécondité. (cf. p.15)

34. Concernant les causes de mortalité en France :

- a) À partir de 65 ans, les décès sont considérés comme naturels et liés au vieillissement. — **VRAI**
Le cours situe ce seuil à 65 ans ; avant cet âge, il évoque une capacité d'accompagner les gens pour qu'ils ne meurent pas, non une mortalité considérée comme naturelle. (cf. p.12)
- b) En France, on compte 600 000 à 650 000 décès par an, avec 646 000 décès en 2024 (augmentation de 6 700 par rapport à 2023). — **VRAI**
Le cours indique précisément 646 000 décès en 2024, en augmentation de 6 700 par rapport à 2023 (639 300). (cf. p.12)
- c) Le taux de mortalité infantile en France est en diminution constante depuis 2018. — **FAUX**
Le cours décrit une augmentation du taux de mortalité infantile, de 3,6 ‰ (2018) à 4,1 ‰ (2024). (cf. p.15)
- d) En 2023, le nombre de décès en France a augmenté de 5,3 % par rapport à l'année précédente. — **FAUX**
Le cours indique une diminution de 5,3 % en 2023 (639 300 décès), et non une augmentation. (cf. p.12)
- e) Pour la première fois en 2025, le nombre de décès en France a dépassé le nombre de naissances, une inversion non observée depuis la guerre. — **VRAI**
Le cours indique explicitement qu'en 2025, pour la première fois, le nombre de décès a dépassé le nombre de naissances, une inversion non observée depuis la guerre. (cf. p.12)

35. Concernant l'espérance de vie :

- a) L'espérance de vie à 35 ans est identique pour les hommes cadres et les hommes ouvriers, à 40 ans. — **FAUX**
Le cours indique des valeurs différentes selon la catégorie professionnelle : 44,5 ans (cadres) contre 38 ans (ouvriers). (cf. p.14)
- b) En 2024, l'espérance de vie féminine en France était la plus élevée d'Europe, devant l'Espagne et l'Allemagne. — **FAUX**
Le cours situe la France devant l'Allemagne mais derrière l'Espagne pour l'espérance de vie féminine en 2024. (cf. p.14)
- c) L'espérance de vie désigne l'âge maximal théorique que peut atteindre un individu. — **FAUX**
La définition du cours est le « nombre moyen probable d'années à vivre », pas un âge maximal théorique. (cf. p.14)
- d) Des baisses brutales de l'espérance de vie sont observées lors des grandes guerres, particulièrement chez les hommes, suivies d'une reprise rapide. — **VRAI**
Le cours mentionne explicitement des « baisses brutales lors des grandes guerres, particulièrement chez les hommes, puis reprise rapide ». (cf. p.14)
- e) L'écart d'espérance de vie entre hommes et femmes s'est progressivement creusé, passant de 5,9 ans en 1997 à 7,8 ans en 2022. — **FAUX**
Le cours décrit une réduction progressive de l'écart, de 7,8 ans (1997) à 5,9 ans (2022), et non un creusement. (cf. p.14)

36. Concernant la définition de la santé selon l'OMS et son évolution :

a) Selon Blum, la santé consiste notamment à se comporter d'une façon qui permette la survie de l'espèce ainsi que l'accomplissement personnel ou le contentement de l'individu. — **VRAI**

Blum décrit deux volets : la capacité de l'organisme à maintenir un équilibre, et un comportement permettant la survie de l'espèce aussi bien que l'accomplissement personnel ou le contentement de l'individu. (cf. p.1)

b) Le concept de santé positive met l'accent sur l'hypothèse d'un développement progressif de la maladie en étapes. — **VRAI**

Le cours associe la santé positive à l'hypothèse d'un développement progressif de la maladie en étapes. (cf. p.2)

c) La santé positive met l'accent sur l'importance de stratégies larges, prenant en compte une combinaison de déterminants. — **VRAI**

Le cours mentionne l'« importance de stratégies larges, prenant en compte une combinaison de déterminants ». (cf. p.2)

d) La frontière entre le normal et le pathologique varie avec l'âge, la culture et l'état de la science. — **VRAI**

Le cours indique explicitement trois facteurs de variabilité de cette frontière : l'âge, la culture, l'état de la science. (cf. p.2)

e) Selon Canguilhem, la notion de santé n'a jamais eu de rapport avec la notion religieuse de salut. — **FAUX**

Canguilhem écrit explicitement que « la santé a remplacé le salut » et qu'être en bonne santé « c'est un luxe biologique ». (cf. p.1)

37. Dans un département de 2 150 000 habitants, on dénombre 20 640 décès sur l'année.

a) Le taux brut de mortalité de ce département est de 9,6 ‰. — **VRAI**

Taux brut de mortalité = décès / population = 20640 / 2150000 × 1000 = 9,6 ‰. (cf. p.12)

b) Le taux brut de mortalité de ce département est de 96,0 ‰. — **FAUX**

Le taux exact est de 9,6 ‰ ; 96,0 ‰ correspond à une erreur d'un facteur 10. (cf. p.12)

c) Le taux brut de mortalité se calcule en divisant le nombre de décès par la population. — **VRAI**

C'est la définition du cours : nombre de décès / population. (cf. p.12)

d) Le taux brut de mortalité se calcule en divisant le nombre de décès par le nombre de naissances vivantes. — **FAUX**

Ce calcul correspond au taux de mortalité infantile, pas au taux brut de mortalité. (cf. p.12)

e) Comparé au taux brut de mortalité national (9,4 ‰ en 2023 et 2024), le taux de ce département est plus élevé. — **VRAI**

9,6 ‰ est plus élevé que le taux national de 9,4 ‰. (cf. p.12)

38. Concernant l'espérance de vie :

a) En France en 2023, l'espérance de vie à la naissance était identique pour les hommes et les femmes, à 82,8 ans. — **FAUX**

Le cours donne des valeurs distinctes : 80,0 ans pour les hommes, 85,7 ans pour les femmes en 2023. (cf. p.14)

b) L'espérance de vie à 35 ans est identique pour les hommes cadres et les hommes ouvriers, à 40 ans. — **FAUX**

Le cours indique des valeurs différentes selon la catégorie professionnelle : 44,5 ans (cadres) contre 38 ans (ouvriers). (cf. p.14)

c) En France, l'espérance de vie est uniforme sur l'ensemble du territoire, sans disparité régionale. — **FAUX**

Le cours mentionne des « disparités régionales marquées, avec une espérance de vie globalement plus faible dans le nord de la France et [les] territoires d'Outre-mer ». (cf. p.14)

d) L'écart d'espérance de vie entre hommes et femmes s'est progressivement creusé, passant de 5,9 ans en 1997 à 7,8 ans en 2022. — **FAUX**

Le cours décrit une réduction progressive de l'écart, de 7,8 ans (1997) à 5,9 ans (2022), et non un creusement. (cf. p.14)

e) En 2024, l'espérance de vie féminine en France (85,8 ans) était supérieure à celle de l'Allemagne, mais inférieure à celle de l'Espagne. — **VRAI**

Le cours situe la France devant l'Allemagne mais derrière l'Espagne pour l'espérance de vie féminine en 2024. (cf. p.14)

39. Au cours d'une épidémie, 150 personnes ont été atteintes par une maladie donnée ; parmi elles, 45 en sont décédées.

- a) La létalité de cette maladie, dans cette population, est de 30,0 %. — **VRAI**
Létalité = décès parmi les malades / nombre de malades = 45 / 150 = 30,0 %. (cf. p.11)
- b) La létalité de cette maladie, dans cette population, est de 300,0 %. — **FAUX**
La létalité exacte est de 30,0 % ; 300,0 % correspond à une erreur d'un facteur 10. (cf. p.11)
- c) La létalité correspond au nombre de décès parmi les malades. — **VRAI**
C'est la définition exacte donnée par le cours. (cf. p.11)
- d) La létalité informe sur la dynamique de la maladie plutôt que sur sa gravité. — **FAUX**
La létalité informe sur la gravité de la maladie ; c'est l'incidence qui informe sur sa dynamique. (cf. p.11)
- e) Le taux de reproduction R de cette épidémie correspond aux cas secondaires engendrés par un cas, et non à la létalité. — **VRAI**
Le taux de reproduction R (cas secondaires engendrés par un cas) est un indicateur distinct de la létalité, qui informe sur la contagiosité. (cf. p.11)

40. Dans un département de 860 000 habitants, on dénombre 7 310 décès sur l'année.

- a) Le taux brut de mortalité de ce département est de 8,5 ‰. — **VRAI**
Taux brut de mortalité = décès / population = 7310 / 860000 × 1000 = 8,5 ‰. (cf. p.12)
- b) Le taux brut de mortalité de ce département est de 85,0 ‰. — **FAUX**
Le taux exact est de 8,5 ‰ ; 85,0 ‰ correspond à une erreur d'un facteur 10. (cf. p.12)
- c) Le taux brut de mortalité se calcule en divisant le nombre de décès par la population. — **VRAI**
C'est la définition du cours : nombre de décès / population. (cf. p.12)
- d) Le taux brut de mortalité se calcule en divisant le nombre de décès par le nombre de naissances vivantes. — **FAUX**
Ce calcul correspond au taux de mortalité infantile, pas au taux brut de mortalité. (cf. p.12)
- e) Comparé au taux brut de mortalité national (9,4 ‰ en 2023 et 2024), le taux de ce département est plus faible. — **VRAI**
8,5 ‰ est plus faible que le taux national de 9,4 ‰. (cf. p.12)

Série 3 — Correction (Questions 41 à 60)

41. Concernant les différentes définitions de la santé et de sa promotion :

- a) Selon Blum, la santé consiste notamment à se comporter d'une façon qui permette la survie de l'espèce ainsi que l'accomplissement personnel ou le contentement de l'individu. — **VRAI**

Blum décrit deux volets : la capacité de l'organisme à maintenir un équilibre, et un comportement permettant la survie de l'espèce aussi bien que l'accomplissement personnel ou le contentement de l'individu. (cf. p.1)

- b) Selon le Petit Robert, la santé est un bon état physiologique, un fonctionnement régulier et harmonieux de l'organisme humain pendant une période appréciable. — **VRAI**

Le Petit Robert définit la santé comme un bon état physiologique et un fonctionnement régulier et harmonieux de l'organisme, et non par la seule absence de maladie. (cf. p.1)

- c) Selon la Conférence d'Ottawa (1986), la promotion de la santé est le processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et de l'améliorer. — **VRAI**

La définition officielle de la Conférence d'Ottawa (1986) est le processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et de l'améliorer. (cf. p.2)

- d) Selon Steichen, la santé correspond à la normalité avec ses caractéristiques. — **VRAI**

La citation de Steichen indique que la santé « correspond à la normalité avec ses caractéristiques ». (cf. p.1)

- e) D'un point de vue physiologique, la santé ne peut être définie par aucune norme du fonctionnement physique ou biologique. — **FAUX**

Le point de vue physiologique définit la santé par des normes de poids, mesures et capacités (visuelle, auditive, respiratoire), donc par des normes du fonctionnement physique et biologique. (cf. p.1)

42. Concernant la mortalité infantile et l'indice synthétique de fécondité :

- a) L'indice synthétique de fécondité (ISF) désigne le nombre d'enfants par femme, et son seuil de remplacement est de 2,1. — **VRAI**

Le cours définit l'ISF comme le nombre d'enfants par femme, avec un seuil de remplacement de 2,1, distinct du taux de fécondité (rapport au nombre de femmes en âge de procréer). (cf. p.15)

- b) Si l'ISF est inférieur au seuil de remplacement, une diminution de la population à long terme est possible, sans apport migratoire. — **VRAI**

Le cours indique qu'un ISF sous le seuil de remplacement rend possible une diminution de la population sans apport migratoire, pas une augmentation garantie. (cf. p.15)

- c) Entre 2009 et 2023, la population française a diminué alors que l'indice synthétique de fécondité a augmenté. — **FAUX**

Le cours indique une hausse de la population (62,6 à 68,4 millions) et une baisse de l'ISF (2,0 à 1,68) sur cette période, soit l'inverse. (cf. p.15)

- d) La portion de population se trouvant en très bonne santé augmente continuellement avec l'âge. — **FAUX**

Le cours décrit une diminution de la très bonne santé perçue avec l'augmentation de l'âge, et non une augmentation. (cf. p.10)

- e) Selon l'enquête Insee 2002-2003, les femmes se trouvent plus souvent en très bonne santé que les hommes. — **FAUX**

Le cours indique 28,2 % des hommes contre 21,5 % des femmes en très bonne santé, donc un avantage masculin sur ce critère. (cf. p.10)

43. Concernant les définitions de la santé :

- a) Selon le Petit Robert, la santé est un bon état physiologique, un fonctionnement régulier et harmonieux de l'organisme humain pendant une période appréciable. — **VRAI**
Le Petit Robert définit la santé comme un bon état physiologique et un fonctionnement régulier et harmonieux de l'organisme, et non par la seule absence de maladie. (cf. p.1)
- b) Selon le chirurgien René Leriche (1936), « la santé c'est la vie dans le bruit des organes ». — **FAUX**
La citation exacte de Leriche (1936) est : « la santé c'est la vie dans le silence des organes ». (cf. p.1)
- c) Selon l'OMS, la santé se définit exclusivement par l'absence de maladie ou d'infirmité. — **FAUX**
La définition de l'OMS précise explicitement que la santé « ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité ». (cf. p.2)
- d) Selon l'OMS, la santé est une ressource pour chaque jour de la vie, et non une finalité de la vie. — **VRAI**
Le cours précise que « la santé est une ressource pour chaque jour de la vie, et n'est pas une finalité de la vie ». (cf. p.2)
- e) Dans le cadre de la santé positive, l'empowerment désigne l'accroissement de l'efficacité individuelle et des appuis sociaux. — **VRAI**
Le cours définit l'empowerment comme un « accroissement de l'efficacité individuelle et des appuis sociaux ». (cf. p.2)

44. Concernant les indicateurs de santé :

- a) Les seuls types d'indicateurs de santé reconnus par le cours sont la mortalité et la morbidité. — **FAUX**
Le cours cite cinq types : mortalité, morbidité, facteurs de risque, handicap, démographiques (ces derniers parfois ajoutés). (cf. p.7)
- b) Un indicateur de santé est un instrument de mesure grâce auquel des ensembles d'informations ou de données vont être agrégés, simplifiés ou résumés. — **VRAI**
La définition du cours insiste sur l'agrégation, la simplification ou le résumé d'ensembles d'informations, pas sur une donnée individuelle brute. (cf. p.7)
- c) Les indicateurs de santé sont des outils de décision et d'intervention pour les gouvernements, les agences de santé publique et les organisations médicales. — **VRAI**
Le cours cite les gouvernements, les agences de santé publique et les organisations médicales comme utilisateurs des indicateurs. (cf. p.7)
- d) La fiabilité (ou reproductibilité) fait partie des propriétés des indicateurs de santé. — **VRAI**
La fiabilité/reproductibilité est listée comme une propriété générale des indicateurs de santé, sans restriction aux seuls indicateurs de mortalité. (cf. p.7)
- e) La complexité d'usage est présentée comme une propriété recherchée des indicateurs de santé. — **FAUX**
Le cours cite la disponibilité, la simplicité à l'usage, la fiabilité et l'exactitude comme propriétés recherchées, pas la complexité. (cf. p.7)

45. Concernant les causes de mortalité en France :

- a) À partir de 65 ans, les décès sont considérés comme naturels et liés au vieillissement. — **VRAI**
Le cours situe ce seuil à 65 ans ; avant cet âge, il évoque une capacité d'accompagner les gens pour qu'ils ne meurent pas, non une mortalité considérée comme naturelle. (cf. p.12)
- b) En 2022, les tumeurs représentaient environ 27 % des décès en France et étaient la première cause de mortalité chez les hommes. — **VRAI**
Le cours précise que les tumeurs sont la 1ère cause de mortalité chez les hommes, alors que les maladies cardiovasculaires sont la 1ère cause chez les femmes. (cf. p.13)
- c) En France, le nombre de naissances a toujours dépassé le nombre de décès depuis la Seconde Guerre mondiale, y compris en 2025. — **FAUX**
Le cours indique explicitement qu'en 2025, pour la première fois, le nombre de décès a dépassé le nombre de naissances, une inversion non observée depuis la guerre. (cf. p.12)
- d) En France, on compte 600 000 à 650 000 décès par an, avec 646 000 décès en 2024 (augmentation de 6 700 par rapport à 2023). — **VRAI**
Le cours indique précisément 646 000 décès en 2024, en augmentation de 6 700 par rapport à 2023 (639 300). (cf. p.12)
- e) La mortalité toutes causes des hommes est plus importante que celle des femmes, pour toutes les classes d'âge. — **VRAI**
Le cours décrit une surmortalité masculine globale, pour toutes les classes d'âge, et non une surmortalité féminine. (cf. p.12)

46. Concernant la complémentarité entre médecine clinique et santé publique :

a) Contrairement à la médecine clinique, la santé publique s'intéresse à la population, à des groupes de personnes. — **VRAI**

C'est la santé publique qui s'intéresse aux groupes de personnes ; la médecine clinique prend en charge une personne. (cf. p.6)

b) La médecine clinique traite la maladie, alors que la santé publique traite de la santé. — **VRAI**

Le tableau de comparaison oppose « traiter la maladie » (médecine clinique) à « traiter de la santé » (santé publique). (cf. p.6)

c) La médecine clinique prend en charge une personne, ce que le cours nomme un « colloque singulier ». — **VRAI**

Le « colloque singulier » désigne la prise en charge d'une personne par la médecine clinique, non l'approche par populations de la santé publique. (cf. p.6)

d) Les maladies d'importation et la réémergence de maladies sont citées comme des conséquences de la mondialisation. — **VRAI**

Le cours classe explicitement les maladies d'importation et la réémergence de maladies parmi les « conséquences de la mondialisation ». (cf. p.6)

e) Parmi les crises sanitaires passées, le cours ne cite aucun exemple antérieur au Covid (2020). — **FAUX**

Le cours cite plusieurs crises antérieures au Covid : amiante (1970), hormone de croissance (1980), sang contaminé (1983), ESB (1985-1991), canicule (2003). (cf. p.6)

47. Dans un département de 540 000 habitants, on dénombre 4 320 décès sur l'année.

a) Le taux brut de mortalité de ce département est de 8,0 ‰. — **VRAI**

Taux brut de mortalité = décès / population = 4320 / 540000 × 1000 = 8,0 ‰. (cf. p.12)

b) Le taux brut de mortalité de ce département est de 80,0 ‰. — **FAUX**

Le taux exact est de 8,0 ‰ ; 80,0 ‰ correspond à une erreur d'un facteur 10. (cf. p.12)

c) Le taux brut de mortalité se calcule en divisant le nombre de décès par la population. — **VRAI**

C'est la définition du cours : nombre de décès / population. (cf. p.12)

d) Le taux brut de mortalité se calcule en divisant le nombre de décès par le nombre de naissances vivantes. — **FAUX**

Ce calcul correspond au taux de mortalité infantile, pas au taux brut de mortalité. (cf. p.12)

e) Comparé au taux brut de mortalité national (9,4 ‰ en 2023 et 2024), le taux de ce département est plus faible. — **VRAI**

8,0 ‰ est plus faible que le taux national de 9,4 ‰. (cf. p.12)

48. Dans une agglomération, on recense 610 cas d'une maladie chronique au 1er janvier de l'année (nombre de cas à cette date), puis 175 nouveaux cas sont diagnostiqués au cours de cette même année.

a) Le nombre de 610 cas recensés au 1er janvier correspond à la prévalence. — **VRAI**

Le nombre de cas à un moment donné correspond à la prévalence. (cf. p.11)

b) Le nombre de 610 cas recensés au 1er janvier correspond à l'incidence. — **FAUX**

Le nombre de cas à un moment donné correspond à la prévalence, pas à l'incidence. (cf. p.11)

c) Le nombre de 175 nouveaux cas diagnostiqués dans l'année correspond à l'incidence. — **VRAI**

Le nombre de nouveaux cas sur une période correspond à l'incidence. (cf. p.11)

d) Le nombre de 175 nouveaux cas diagnostiqués dans l'année correspond à la létalité. — **FAUX**

La létalité correspond au nombre de décès parmi les malades, pas au nombre de nouveaux cas. (cf. p.11)

e) L'incidence de cette maladie permet notamment de savoir s'il y a épidémie ou non. — **VRAI**

Le cours associe explicitement l'incidence à la question de savoir s'il y a épidémie ou non. (cf. p.11)

49. Concernant les causes de mortalité en France :

a) En 2022, les tumeurs représentaient environ 27 % des décès en France et étaient la première cause de mortalité chez les femmes. — **FAUX**

Le cours précise que les tumeurs sont la 1ère cause de mortalité chez les hommes, alors que les maladies cardiovasculaires sont la 1ère cause chez les femmes. (cf. p.13)

b) Entre 1980 et 2004, les décès liés aux maladies cardiovasculaires ont fortement augmenté, malgré le développement de nouvelles thérapeutiques. — **FAUX**

Le cours décrit une diminution des décès cardiovasculaires sur cette période, liée aux progrès thérapeutiques. (cf. p.13)

c) En 2023, le nombre de décès en France a diminué de 5,3 % par rapport à l'année précédente. — **VRAI**

Le cours indique une diminution de 5,3 % en 2023 (639 300 décès), et non une augmentation. (cf. p.12)

d) La mortalité toutes causes des femmes est plus importante que celle des hommes, sauf après 65 ans. — **FAUX**

Le cours décrit une surmortalité masculine globale, pour toutes les classes d'âge, et non une surmortalité féminine. (cf. p.12)

e) Pour la première fois en 2025, le nombre de décès en France a dépassé le nombre de naissances, une inversion non observée depuis la guerre. — **VRAI**

Le cours indique explicitement qu'en 2025, pour la première fois, le nombre de décès a dépassé le nombre de naissances, une inversion non observée depuis la guerre. (cf. p.12)

50. Dans un établissement scolaire, on recense 95 cas d'une maladie chronique au 1er janvier de l'année (nombre de cas à cette date), puis 31 nouveaux cas sont diagnostiqués au cours de cette même année.

a) Le nombre de 95 cas recensés au 1er janvier correspond à la prévalence. — **VRAI**

Le nombre de cas à un moment donné correspond à la prévalence. (cf. p.11)

b) Le nombre de 95 cas recensés au 1er janvier correspond à l'incidence. — **FAUX**

Le nombre de cas à un moment donné correspond à la prévalence, pas à l'incidence. (cf. p.11)

c) Le nombre de 31 nouveaux cas diagnostiqués dans l'année correspond à l'incidence. — **VRAI**

Le nombre de nouveaux cas sur une période correspond à l'incidence. (cf. p.11)

d) Le nombre de 31 nouveaux cas diagnostiqués dans l'année correspond à la létalité. — **FAUX**

La létalité correspond au nombre de décès parmi les malades, pas au nombre de nouveaux cas. (cf. p.11)

e) L'incidence de cette maladie permet notamment de savoir s'il y a épidémie ou non. — **VRAI**

Le cours associe explicitement l'incidence à la question de savoir s'il y a épidémie ou non. (cf. p.11)

51. Dans un département de 1 780 000 habitants, on dénombre 19 580 décès sur l'année.

a) Le taux brut de mortalité de ce département est de 11,0 ‰. — **VRAI**

Taux brut de mortalité = décès / population = 19580 / 1780000 × 1000 = 11,0 ‰. (cf. p.12)

b) Le taux brut de mortalité de ce département est de 110,0 ‰. — **FAUX**

Le taux exact est de 11,0 ‰ ; 110,0 ‰ correspond à une erreur d'un facteur 10. (cf. p.12)

c) Le taux brut de mortalité se calcule en divisant le nombre de décès par la population. — **VRAI**

C'est la définition du cours : nombre de décès / population. (cf. p.12)

d) Le taux brut de mortalité se calcule en divisant le nombre de décès par le nombre de naissances vivantes. — **FAUX**

Ce calcul correspond au taux de mortalité infantile, pas au taux brut de mortalité. (cf. p.12)

e) Comparé au taux brut de mortalité national (9,4 ‰ en 2023 et 2024), le taux de ce département est plus élevé. — **VRAI**

11,0 ‰ est plus élevé que le taux national de 9,4 ‰. (cf. p.12)

52. Dans un département de 3 400 000 habitants, on dénombre 37 400 décès sur l'année.

- a) Le taux brut de mortalité de ce département est de 11,0 ‰. — **VRAI**
Taux brut de mortalité = décès / population = 37400 / 3400000 × 1000 = 11,0 ‰. (cf. p.12)
- b) Le taux brut de mortalité de ce département est de 110,0 ‰. — **FAUX**
Le taux exact est de 11,0 ‰ ; 110,0 ‰ correspond à une erreur d'un facteur 10. (cf. p.12)
- c) Le taux brut de mortalité se calcule en divisant le nombre de décès par la population. — **VRAI**
C'est la définition du cours : nombre de décès / population. (cf. p.12)
- d) Le taux brut de mortalité se calcule en divisant le nombre de décès par le nombre de naissances vivantes. — **FAUX**
Ce calcul correspond au taux de mortalité infantile, pas au taux brut de mortalité. (cf. p.12)
- e) Comparé au taux brut de mortalité national (9,4 ‰ en 2023 et 2024), le taux de ce département est plus élevé. — **VRAI**
11,0 ‰ est plus élevé que le taux national de 9,4 ‰. (cf. p.12)

53. Dans un service hospitalier, on recense 78 cas d'une maladie chronique au 1er janvier de l'année (nombre de cas à cette date), puis 22 nouveaux cas sont diagnostiqués au cours de cette même année.

- a) Le nombre de 78 cas recensés au 1er janvier correspond à la prévalence. — **VRAI**
Le nombre de cas à un moment donné correspond à la prévalence. (cf. p.11)
- b) Le nombre de 78 cas recensés au 1er janvier correspond à l'incidence. — **FAUX**
Le nombre de cas à un moment donné correspond à la prévalence, pas à l'incidence. (cf. p.11)
- c) Le nombre de 22 nouveaux cas diagnostiqués dans l'année correspond à l'incidence. — **VRAI**
Le nombre de nouveaux cas sur une période correspond à l'incidence. (cf. p.11)
- d) Le nombre de 22 nouveaux cas diagnostiqués dans l'année correspond à la létalité. — **FAUX**
La létalité correspond au nombre de décès parmi les malades, pas au nombre de nouveaux cas. (cf. p.11)
- e) L'incidence de cette maladie permet notamment de savoir s'il y a épidémie ou non. — **VRAI**
Le cours associe explicitement l'incidence à la question de savoir s'il y a épidémie ou non. (cf. p.11)

54. Concernant la complémentarité entre médecine clinique et santé publique :

- a) Le terme « colloque singulier » désigne, dans le cours, l'approche de la santé publique par populations. — **FAUX**
Le « colloque singulier » désigne la prise en charge d'une personne par la médecine clinique, non l'approche par populations de la santé publique. (cf. p.6)
- b) Les indicateurs de santé sont présentés comme une conséquence de la mondialisation, au même titre que les maladies d'importation. — **FAUX**
Le cours distingue les « Raisons » (crises sanitaires, mondialisation, inégalités...) des « Moyens », qui sont les indicateurs de santé. (cf. p.6)
- c) Les maladies d'importation sont présentées comme sans lien avec le phénomène de mondialisation. — **FAUX**
Le cours classe explicitement les maladies d'importation et la réémergence de maladies parmi les « conséquences de la mondialisation ». (cf. p.6)
- d) La médecine clinique traite la maladie, alors que la santé publique traite de la santé. — **VRAI**
Le tableau de comparaison oppose « traiter la maladie » (médecine clinique) à « traiter de la santé » (santé publique). (cf. p.6)
- e) Contrairement à la santé publique, la médecine clinique s'intéresse en priorité à des groupes de personnes plutôt qu'à un patient individuel. — **FAUX**
C'est la santé publique qui s'intéresse aux groupes de personnes ; la médecine clinique prend en charge une personne. (cf. p.6)

55. Concernant l'espérance de vie :

a) En 2024, l'espérance de vie féminine en France (85,8 ans) était supérieure à celle de l'Allemagne, mais inférieure à celle de l'Espagne. — **VRAI**

Le cours situe la France devant l'Allemagne mais derrière l'Espagne pour l'espérance de vie féminine en 2024. (cf. p.14)

b) En France en 2023, l'espérance de vie à la naissance était identique pour les hommes et les femmes, à 82,8 ans. — **FAUX**

Le cours donne des valeurs distinctes : 80,0 ans pour les hommes, 85,7 ans pour les femmes en 2023. (cf. p.14)

c) L'écart d'espérance de vie entre hommes et femmes s'est progressivement réduit, passant de 7,8 ans en 1997 à 5,9 ans en 2022. — **VRAI**

Le cours décrit une réduction progressive de l'écart, de 7,8 ans (1997) à 5,9 ans (2022), et non un creusement. (cf. p.14)

d) L'espérance de vie à 35 ans est identique pour les hommes cadres et les hommes ouvriers, à 40 ans. — **FAUX**

Le cours indique des valeurs différentes selon la catégorie professionnelle : 44,5 ans (cadres) contre 38 ans (ouvriers). (cf. p.14)

e) En France, l'espérance de vie est uniforme sur l'ensemble du territoire, sans disparité régionale. — **FAUX**

Le cours mentionne des « disparités régionales marquées, avec une espérance de vie globalement plus faible dans le nord de la France et [les] territoires d'Outre-mer ». (cf. p.14)

56. Concernant la mortalité en France :

a) À partir de 65 ans, les décès sont considérés comme naturels et liés au vieillissement. — **VRAI**

Le cours situe ce seuil à 65 ans ; avant cet âge, il évoque une capacité d'accompagner les gens pour qu'ils ne meurent pas, non une mortalité considérée comme naturelle. (cf. p.12)

b) En France, le nombre de naissances a toujours dépassé le nombre de décès depuis la Seconde Guerre mondiale, y compris en 2025. — **FAUX**

Le cours indique explicitement qu'en 2025, pour la première fois, le nombre de décès a dépassé le nombre de naissances, une inversion non observée depuis la guerre. (cf. p.12)

c) En France, on compte 600 000 à 650 000 décès par an, avec 600 000 décès en 2024 (diminution par rapport à 2023). — **FAUX**

Le cours indique précisément 646 000 décès en 2024, en augmentation de 6 700 par rapport à 2023 (639 300). (cf. p.12)

d) Le taux de mortalité infantile en France est en diminution constante depuis 2018. — **FAUX**

Le cours décrit une augmentation du taux de mortalité infantile, de 3,6 ‰ (2018) à 4,1 ‰ (2024). (cf. p.15)

e) En 2022, le nombre de décès en France a augmenté, notamment en lien avec le Covid, la grippe et la canicule. — **VRAI**

Le cours indique 670 000 décès en 2022, en augmentation, liée au Covid, à la grippe et à la canicule. (cf. p.12)

57. Concernant la définition de la santé selon l'OMS et son évolution :

- a) Selon la Conférence d'Ottawa (1986), la promotion de la santé est le processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et de l'améliorer. — **VRAI**
La définition officielle de la Conférence d'Ottawa (1986) est le processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et de l'améliorer. (cf. p.2)
- b) Le Dry January et le mois sans tabac sont cités comme exemples de mesures de dépistage obligatoire. — **FAUX**
Le cours cite ces deux campagnes parmi les exemples de campagnes de promotion de la santé, non comme des mesures de dépistage. (cf. p.2)
- c) Selon le microbiologiste R. Dubos, la santé est un état physique et mental relativement exempt de gêne et de souffrance. — **VRAI**
Dubos définit la santé comme un état physique ET mental relativement exempt de gêne et de souffrance, pas uniquement mental. (cf. p.1)
- d) Selon la Charte d'Ottawa, la santé est perçue comme une ressource de la vie quotidienne, et non comme le but de la vie. — **VRAI**
Le cours précise que « la santé est donc perçue comme une ressource de la vie quotidienne et non comme le but de la vie ». (cf. p.2)
- e) Selon Canguilhem, « la santé a remplacé le salut » et être en bonne santé est « un luxe biologique ». — **VRAI**
Canguilhem écrit explicitement que « la santé a remplacé le salut » et qu'être en bonne santé « c'est un luxe biologique ». (cf. p.1)

58. Concernant la définition de la santé selon l'OMS et son évolution :

- a) Selon le chirurgien René Leriche (1936), « la santé c'est la vie dans le bruit des organes ». — **FAUX**
La citation exacte de Leriche (1936) est : « la santé c'est la vie dans le silence des organes ». (cf. p.1)
- b) Le concept de santé positive met l'accent sur l'hypothèse d'un développement progressif de la maladie en étapes. — **VRAI**
Le cours associe la santé positive à l'hypothèse d'un développement progressif de la maladie en étapes. (cf. p.2)
- c) Selon la Conférence d'Ottawa (1986), la promotion de la santé désigne exclusivement les campagnes de communication gouvernementales sur la santé. — **FAUX**
La définition officielle de la Conférence d'Ottawa (1986) est le processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et de l'améliorer. (cf. p.2)
- d) Selon Cotton (1982), la vie peut être considérée comme un rythme continu d'interactions et un état d'équilibre instable. — **VRAI**
Cotton décrit un « état d'équilibre instable » et un bien-être qui « n'est jamais qu'un état passager à reconquérir sans cesse ». (cf. p.1)
- e) Selon Steichen, la santé correspond à l'absence totale de toute variabilité individuelle. — **FAUX**
La citation de Steichen indique que la santé « correspond à la normalité avec ses caractéristiques ». (cf. p.1)

59. Concernant la mortalité en France :

- a) Avant 65 ans, les décès sont systématiquement considérés comme naturels et liés au vieillissement. — **FAUX**
Le cours situe ce seuil à 65 ans ; avant cet âge, il évoque une capacité d'accompagner les gens pour qu'ils ne meurent pas, non une mortalité considérée comme naturelle. (cf. p.12)
- b) Le taux de mortalité infantile en France est en augmentation, passant de 3,6 ‰ en 2018 à 4,1 ‰ en 2024. — **VRAI**
Le cours décrit une augmentation du taux de mortalité infantile, de 3,6 ‰ (2018) à 4,1 ‰ (2024). (cf. p.15)
- c) Le taux de mortalité infantile se calcule en divisant le nombre de décès avant l'âge de 1 an par le nombre de naissances vivantes, et s'élevait à 4,1 ‰ en France en 2024. — **VRAI**
Le calcul officiel du cours divise les décès avant 1 an par le nombre de naissances vivantes, pas par la population totale (ce qui correspond au taux brut de mortalité). (cf. p.12)
- d) En 2000, les maladies cardiovasculaires étaient la 1ère cause de décès et les tumeurs la 2e ; en 2008, ce rang s'est inversé. — **VRAI**
Le cours décrit une inversion : rang 1 cardiovasculaire / rang 2 tumeurs en 2000, puis rang 1 tumeurs / rang 2 cardiovasculaire en 2008. (cf. p.13)
- e) En France, on compte 600 000 à 650 000 décès par an, avec 600 000 décès en 2024 (diminution par rapport à 2023). — **FAUX**
Le cours indique précisément 646 000 décès en 2024, en augmentation de 6 700 par rapport à 2023 (639 300). (cf. p.12)

60. Concernant les registres des cancers :

a) La population de référence des registres des cancers est le plus souvent celle du département. —

VRAI

Le cours précise que la population de référence est « le plus souvent » celle du département, pas systématiquement le territoire national. (cf. p.9)

b) Le CépiDc est un registre exclusivement dédié aux cancers colorectaux. — **FAUX**

Le CépiDc centralise les causes de décès (accès libre sur internet), pas spécifiquement les cancers colorectaux (ce sont les registres des cancers). (cf. p.8)

c) Les informations des registres des cancers proviennent des anatomo-pathologistes, des biologistes et des cliniciens. — **VRAI**

Le cours cite trois sources professionnelles : anatomo-pathologistes, biologistes, cliniciens. (cf. p.9)

d) Le big data en santé se caractérise par une explosion quantitative des données numériques et une haute technicité. — **VRAI**

Le cours décrit au contraire une « explosion quantitative des données numériques ». (cf. p.8)

e) Les MDO et les données de l'Insee/INED sont présentées comme des sources exclusivement utilisées en dehors de la France. — **FAUX**

Le cours liste les MDO et les données démographiques (Insee, INED) parmi les différentes sources de données françaises. (cf. p.8)

Série 4 — Correction (Questions 61 à 80)

61. Concernant les indicateurs de santé :

- a) Les indicateurs de santé sont réservés à l'usage exclusif des cliniciens en cabinet privé. — **FAUX**
Le cours cite les gouvernements, les agences de santé publique et les organisations médicales comme utilisateurs des indicateurs. (cf. p.7)
- b) La disponibilité, la simplicité à l'usage et l'exactitude font partie des propriétés des indicateurs de santé. — **VRAI**
Le cours cite la disponibilité, la simplicité à l'usage, la fiabilité et l'exactitude comme propriétés recherchées, pas la complexité. (cf. p.7)
- c) Un indicateur de santé est un instrument de mesure grâce auquel des ensembles d'informations ou de données vont être agrégés, simplifiés ou résumés. — **VRAI**
La définition du cours insiste sur l'agrégation, la simplification ou le résumé d'ensembles d'informations, pas sur une donnée individuelle brute. (cf. p.7)
- d) La fiabilité (ou reproductibilité) est présentée comme une propriété exclusive des seuls indicateurs de mortalité. — **FAUX**
La fiabilité/reproductibilité est listée comme une propriété générale des indicateurs de santé, sans restriction aux seuls indicateurs de mortalité. (cf. p.7)
- e) Les seuls types d'indicateurs de santé reconnus par le cours sont la mortalité et la morbidité. — **FAUX**
Le cours cite cinq types : mortalité, morbidité, facteurs de risque, handicap, démographiques (ces derniers parfois ajoutés). (cf. p.7)

62. Concernant les missions et la définition de la santé publique :

- a) Dans la règle des 5P, la Prévision vise à surveiller les maladies et les risques pour la santé. — **VRAI**
Surveiller les maladies et les risques correspond à la Prévision ; donner des soins correspond à la Provision. (cf. p.5)
- b) Dans la règle des 5P, la Prévention vise à éviter la survenue de maladies, par exemple par la vaccination ou le dépistage. — **VRAI**
Éviter la survenue de maladies (vaccination, dépistage) correspond à la Prévention ; enrayer la propagation correspond à la Protection. (cf. p.5)
- c) Selon l'OMS (1952), organiser des services médicaux et infirmiers en vue du diagnostic précoce et du traitement préventif des maladies fait partie de l'action collective concertée. — **VRAI**
Le cours liste explicitement « organiser des services médicaux et infirmiers en vue du diagnostic précoce et du traitement préventif des maladies » parmi les actions visées. (cf. p.3)
- d) Selon l'OMS (1952), l'objet final de la santé publique est de réduire les dépenses de l'État en matière de santé. — **FAUX**
Le cours précise que « l'objet final [est] de permettre à chaque individu de jouir de son droit inné à la santé et à la longévité ». (cf. p.3)
- e) La règle des 5P regroupe la Protection, la Prévention, la Promotion, la Prévision et la Provision. — **VRAI**
Les 5P du cours sont : Protection, Prévention, Promotion, Prévision, Provision. (cf. p.5)

63. Concernant l'histoire et la structuration de la santé publique :

a) L'épidémie de peste noire a débuté en 1347 à Marseille et a causé 30 à 50 % de décès en Europe. —

VRAI

Le cours date la peste noire de 1347, à Marseille, avec 30-50 % de décès en Europe. (cf. p.4)

b) La loi relative à la protection de la santé publique date de 1952, année de la définition de l'OMS. —

FAUX

Le cours date cette loi de 1902, distincte de la définition de l'OMS qui date de 1952. (cf. p.4)

c) Louis Pasteur est associé exclusivement à la création des hôpitaux au Moyen Âge. — **FAUX**

Le cours associe Pasteur à l'hypothèse des agents infectieux, la pasteurisation et l'asepsie chirurgicale, pas aux hôpitaux (Moyen Âge). (cf. p.4)

d) Le Serment d'Hippocrate pose la déontologie de la pratique médicale, avec notamment des soins gratuits à l'indigent. — **VRAI**

Le cours associe le Serment d'Hippocrate à la déontologie de la pratique médicale et aux soins gratuits à l'indigent. (cf. p.4)

e) Le courant hygiéniste (19e-début 20e siècle) correspond à l'émergence de l'épidémiologie, de l'hygiène et de la prévention. — **VRAI**

Le cours définit le courant hygiéniste comme l'émergence de l'épidémiologie, de l'hygiène et de la prévention. (cf. p.4)

64. Dans une région, on recense 520 cas d'une maladie chronique au 1er janvier de l'année (nombre de cas à cette date), puis 140 nouveaux cas sont diagnostiqués au cours de cette même année.

a) Le nombre de 520 cas recensés au 1er janvier correspond à la prévalence. — **VRAI**

Le nombre de cas à un moment donné correspond à la prévalence. (cf. p.11)

b) Le nombre de 520 cas recensés au 1er janvier correspond à l'incidence. — **FAUX**

Le nombre de cas à un moment donné correspond à la prévalence, pas à l'incidence. (cf. p.11)

c) Le nombre de 140 nouveaux cas diagnostiqués dans l'année correspond à l'incidence. — **VRAI**

Le nombre de nouveaux cas sur une période correspond à l'incidence. (cf. p.11)

d) Le nombre de 140 nouveaux cas diagnostiqués dans l'année correspond à la létalité. — **FAUX**

La létalité correspond au nombre de décès parmi les malades, pas au nombre de nouveaux cas. (cf. p.11)

e) L'incidence de cette maladie permet notamment de savoir s'il y a épidémie ou non. — **VRAI**

Le cours associe explicitement l'incidence à la question de savoir s'il y a épidémie ou non. (cf. p.11)

65. Concernant la règle des 5P et la santé publique :

a) En tant que discipline autonome, la santé publique s'occupe exclusivement de l'état de santé individuel d'un patient donné. — **FAUX**

Le cours définit la santé publique comme s'occupant de la santé globale des populations, non d'un individu isolé. (cf. p.5)

b) Selon l'OMS (1952), l'objet final de la santé publique est de permettre à chaque individu de jouir de son droit inné à la santé et à la longévité. — **VRAI**

Le cours précise que « l'objet final [est] de permettre à chaque individu de jouir de son droit inné à la santé et à la longévité ». (cf. p.3)

c) La règle des 5P regroupe la Prévention, la Protection, la Population, la Pathologie et la Provision. —

FAUX

Les 5P du cours sont : Protection, Prévention, Promotion, Prévision, Provision. (cf. p.5)

d) Selon l'OMS (1952), organiser des services médicaux et infirmiers en vue du diagnostic précoce et du traitement préventif des maladies fait partie de l'action collective concertée. — **VRAI**

Le cours liste explicitement « organiser des services médicaux et infirmiers en vue du diagnostic précoce et du traitement préventif des maladies » parmi les actions visées. (cf. p.3)

e) Selon l'OMS (1952), la santé publique repose exclusivement sur l'action individuelle de chaque patient, sans dimension collective. — **FAUX**

La définition de l'OMS (1952) insiste sur une action collective concertée, et non sur la seule action individuelle. (cf. p.3)

66. Concernant la définition de la santé selon l'OMS et son évolution :

a) Le Dry January et le mois sans tabac en novembre sont cités comme exemples de campagnes de promotion de la santé. — **VRAI**

Le cours cite ces deux campagnes parmi les exemples de campagnes de promotion de la santé, non comme des mesures de dépistage. (cf. p.2)

b) Selon le sociologue R. Bastide, l'homme sain est celui qui est capable de riposter à un monde complexe et mouvant. — **VRAI**

Bastide décrit l'homme sain comme celui qui s'ajuste moins au monde qu'il n'est capable de le modifier, donc un rôle actif et non passif. (cf. p.1)

c) Selon le Petit Robert, la santé est un bon état physiologique, un fonctionnement régulier et harmonieux de l'organisme humain pendant une période appréciable. — **VRAI**

Le Petit Robert définit la santé comme un bon état physiologique et un fonctionnement régulier et harmonieux de l'organisme, et non par la seule absence de maladie. (cf. p.1)

d) La santé positive privilégie des stratégies ciblées sur un déterminant unique, à l'exclusion de toute combinaison. — **FAUX**

Le cours mentionne l'« importance de stratégies larges, prenant en compte une combinaison de déterminants ». (cf. p.2)

e) Selon le microbiologiste R. Dubos, la santé se définit uniquement par des critères mentaux, indépendamment de l'état physique. — **FAUX**

Dubos définit la santé comme un état physique ET mental relativement exempt de gêne et de souffrance, pas uniquement mental. (cf. p.1)

67. Concernant les causes de mortalité en France :

a) Le taux de mortalité infantile en France est en augmentation, passant de 3,6 ‰ en 2018 à 4,1 ‰ en 2024. — **VRAI**

Le cours décrit une augmentation du taux de mortalité infantile, de 3,6 ‰ (2018) à 4,1 ‰ (2024). (cf. p.15)

b) Entre 1980 et 2004, les décès liés aux maladies tumorales et aux cancers ont diminué aussi fortement que ceux liés aux maladies cardiovasculaires. — **FAUX**

Le cours oppose la diminution des décès cardiovasculaires à la « très grande stabilité » des décès tumoraux/cancers. (cf. p.13)

c) La mortalité toutes causes des femmes est plus importante que celle des hommes, sauf après 65 ans. — **FAUX**

Le cours décrit une surmortalité masculine globale, pour toutes les classes d'âge, et non une surmortalité féminine. (cf. p.12)

d) Le taux brut de mortalité se calcule en divisant le nombre de décès par le nombre de naissances vivantes. — **FAUX**

Diviser les décès par les naissances vivantes correspond au calcul du taux de mortalité infantile, pas du taux brut de mortalité (décès/population). (cf. p.12)

e) En 2023, le nombre de décès en France a augmenté de 5,3 % par rapport à l'année précédente. — **FAUX**

Le cours indique une diminution de 5,3 % en 2023 (639 300 décès), et non une augmentation. (cf. p.12)

68. Au cours d'une épidémie, 500 personnes ont été atteintes par une maladie donnée ; parmi elles, 25 en sont décédées.

a) La létalité de cette maladie, dans cette population, est de 5,0 %. — **VRAI**

Létalité = décès parmi les malades / nombre de malades = 25 / 500 = 5,0 %. (cf. p.11)

b) La létalité de cette maladie, dans cette population, est de 50,0 %. — **FAUX**

La létalité exacte est de 5,0 % ; 50,0 % correspond à une erreur d'un facteur 10. (cf. p.11)

c) La létalité correspond au nombre de décès parmi les malades. — **VRAI**

C'est la définition exacte donnée par le cours. (cf. p.11)

d) La létalité informe sur la dynamique de la maladie plutôt que sur sa gravité. — **FAUX**

La létalité informe sur la gravité de la maladie ; c'est l'incidence qui informe sur sa dynamique. (cf. p.11)

e) Le taux de reproduction R de cette épidémie correspond aux cas secondaires engendrés par un cas, et non à la létalité. — **VRAI**

Le taux de reproduction R (cas secondaires engendrés par un cas) est un indicateur distinct de la létalité, qui informe sur la contagiosité. (cf. p.11)

69. Concernant l'espérance de vie :

- a) L'espérance de vie désigne l'âge maximal théorique que peut atteindre un individu. — **FAUX**

La définition du cours est le « nombre moyen probable d'années à vivre », pas un âge maximal théorique. (cf. p.14)

- b) En 2024, l'espérance de vie féminine en France était la plus élevée d'Europe, devant l'Espagne et l'Allemagne. — **FAUX**

Le cours situe la France devant l'Allemagne mais derrière l'Espagne pour l'espérance de vie féminine en 2024. (cf. p.14)

- c) L'espérance de vie n'a jamais connu de baisse brutale au cours du 20e siècle, y compris pendant les grandes guerres. — **FAUX**

Le cours mentionne explicitement des « baisses brutales lors des grandes guerres, particulièrement chez les hommes, puis reprise rapide ». (cf. p.14)

- d) L'espérance de vie à 35 ans est de 44,5 ans pour les hommes cadres, contre 38 ans pour les hommes ouvriers. — **VRAI**

Le cours indique des valeurs différentes selon la catégorie professionnelle : 44,5 ans (cadres) contre 38 ans (ouvriers). (cf. p.14)

- e) En France, l'espérance de vie est globalement plus faible dans le nord de la France et dans les territoires d'Outre-mer. — **VRAI**

Le cours mentionne des « disparités régionales marquées, avec une espérance de vie globalement plus faible dans le nord de la France et [les] territoires d'Outre-mer ». (cf. p.14)

70. Au cours d'une épidémie, 620 personnes ont été atteintes par une maladie donnée ; parmi elles, 62 en sont décédées.

- a) La létalité de cette maladie, dans cette population, est de 10,0 %. — **VRAI**

Létalité = décès parmi les malades / nombre de malades = 62 / 620 = 10,0 %. (cf. p.11)

- b) La létalité de cette maladie, dans cette population, est de 100,0 %. — **FAUX**

La létalité exacte est de 10,0 % ; 100,0 % correspond à une erreur d'un facteur 10. (cf. p.11)

- c) La létalité correspond au nombre de décès parmi les malades. — **VRAI**

C'est la définition exacte donnée par le cours. (cf. p.11)

- d) La létalité informe sur la dynamique de la maladie plutôt que sur sa gravité. — **FAUX**

La létalité informe sur la gravité de la maladie ; c'est l'incidence qui informe sur sa dynamique. (cf. p.11)

- e) Le taux de reproduction R de cette épidémie correspond aux cas secondaires engendrés par un cas, et non à la létalité. — **VRAI**

Le taux de reproduction R (cas secondaires engendrés par un cas) est un indicateur distinct de la létalité, qui informe sur la contagiosité. (cf. p.11)

71. Au cours d'une épidémie, 240 personnes ont été atteintes par une maladie donnée ; parmi elles, 36 en sont décédées.

- a) La létalité de cette maladie, dans cette population, est de 15,0 %. — **VRAI**

Létalité = décès parmi les malades / nombre de malades = 36 / 240 = 15,0 %. (cf. p.11)

- b) La létalité de cette maladie, dans cette population, est de 150,0 %. — **FAUX**

La létalité exacte est de 15,0 % ; 150,0 % correspond à une erreur d'un facteur 10. (cf. p.11)

- c) La létalité correspond au nombre de décès parmi les malades. — **VRAI**

C'est la définition exacte donnée par le cours. (cf. p.11)

- d) La létalité informe sur la dynamique de la maladie plutôt que sur sa gravité. — **FAUX**

La létalité informe sur la gravité de la maladie ; c'est l'incidence qui informe sur sa dynamique. (cf. p.11)

- e) Le taux de reproduction R de cette épidémie correspond aux cas secondaires engendrés par un cas, et non à la létalité. — **VRAI**

Le taux de reproduction R (cas secondaires engendrés par un cas) est un indicateur distinct de la létalité, qui informe sur la contagiosité. (cf. p.11)

72. Concernant la morbidité et les indicateurs de morbidité :

a) Selon l'enquête Insee 2002-2003, les hommes se trouvent plus souvent en très bonne santé que les femmes. — **VRAI**

Le cours indique 28,2 % des hommes contre 21,5 % des femmes en très bonne santé, donc un avantage masculin sur ce critère. (cf. p.10)

b) La mortalité, en épidémiologie descriptive, correspond au nombre de décès, mesuré par des indicateurs de mortalité brute ou spécifique. — **VRAI**

Le nombre de nouveaux cas correspond à l'incidence, non à la mortalité qui correspond au nombre de décès. (cf. p.11)

c) Les 3 types de morbidité sont la morbidité aiguë, la morbidité chronique et la morbidité mixte. — **FAUX**

Le cours cite précisément : morbidité ressentie, morbidité diagnostiquée, morbidité réelle. (cf. p.10)

d) Comparés aux femmes, les hommes déclarent moins souffrir d'une maladie, alors qu'ils sont pourtant les plus atteints de maladies. — **VRAI**

Le cours souligne un paradoxe : les hommes déclarent moins souffrir de maladies, bien qu'ils soient les plus atteints. (cf. p.10)

e) L'incidence correspond au nombre de nouveaux cas sur une période de temps, et informe sur la dynamique de la maladie. — **VRAI**

Le nombre de décès parmi les malades correspond à la létalité (gravité), pas à l'incidence (dynamique/nouveaux cas). (cf. p.11)

73. Concernant les registres des cancers :

a) Il existe 25 registres des cancers en France, dont 14 registres généraux et 11 registres spécialisés. — **VRAI**

Le cours indique 25 registres au total en France : 14 généraux et 11 spécialisés. (cf. p.9)

b) Les informations des registres des cancers proviennent des anatomo-pathologistes, des biologistes et des cliniciens. — **VRAI**

Le cours cite trois sources professionnelles : anatomo-pathologistes, biologistes, cliniciens. (cf. p.9)

c) La population de référence des registres des cancers est le plus souvent celle du département. — **VRAI**

Le cours précise que la population de référence est « le plus souvent » celle du département, pas systématiquement le territoire national. (cf. p.9)

d) Le CépiDc est une source de données sur les causes de décès en France, en accès libre sur internet. — **VRAI**

Le CépiDc centralise les causes de décès (accès libre sur internet), pas spécifiquement les cancers colorectaux (ce sont les registres des cancers). (cf. p.8)

e) Les maladies à déclaration obligatoire (MDO) et les données démographiques (Insee, INED) font partie des sources de données en santé publique en France. — **VRAI**

Le cours liste les MDO et les données démographiques (Insee, INED) parmi les différentes sources de données françaises. (cf. p.8)

74. Dans un département, on recense 1250 cas d'une maladie chronique au 1er janvier de l'année (nombre de cas à cette date), puis 310 nouveaux cas sont diagnostiqués au cours de cette même année.

a) Le nombre de 1250 cas recensés au 1er janvier correspond à la prévalence. — **VRAI**

Le nombre de cas à un moment donné correspond à la prévalence. (cf. p.11)

b) Le nombre de 1250 cas recensés au 1er janvier correspond à l'incidence. — **FAUX**

Le nombre de cas à un moment donné correspond à la prévalence, pas à l'incidence. (cf. p.11)

c) Le nombre de 310 nouveaux cas diagnostiqués dans l'année correspond à l'incidence. — **VRAI**

Le nombre de nouveaux cas sur une période correspond à l'incidence. (cf. p.11)

d) Le nombre de 310 nouveaux cas diagnostiqués dans l'année correspond à la létalité. — **FAUX**

La létalité correspond au nombre de décès parmi les malades, pas au nombre de nouveaux cas. (cf. p.11)

e) L'incidence de cette maladie permet notamment de savoir s'il y a épidémie ou non. — **VRAI**

Le cours associe explicitement l'incidence à la question de savoir s'il y a épidémie ou non. (cf. p.11)

75. Concernant la complémentarité entre médecine clinique et santé publique :

a) La santé publique repose exclusivement sur des méthodes thérapeutiques individuelles, à l'exclusion de l'épidémiologie. — **FAUX**

Le tableau attribue les méthodes thérapeutiques à la médecine clinique, et l'épidémiologie/administration de la santé/sociologie à la santé publique. (cf. p.6)

b) Parmi les crises sanitaires passées justifiant de mesurer l'état de santé figurent l'amiante (1970), le sang contaminé (1983) et le Covid (2020). — **VRAI**

Le cours cite plusieurs crises antérieures au Covid : amiante (1970), hormone de croissance (1980), sang contaminé (1983), ESB (1985-1991), canicule (2003). (cf. p.6)

c) Les maladies d'importation sont présentées comme sans lien avec le phénomène de mondialisation. — **FAUX**

Le cours classe explicitement les maladies d'importation et la réémergence de maladies parmi les « conséquences de la mondialisation ». (cf. p.6)

d) La médecine clinique et la santé publique ont exactement le même objet, la maladie. — **FAUX**

Le tableau de comparaison oppose « traiter la maladie » (médecine clinique) à « traiter de la santé » (santé publique). (cf. p.6)

e) Les indicateurs de santé sont présentés comme une conséquence de la mondialisation, au même titre que les maladies d'importation. — **FAUX**

Le cours distingue les « Raisons » (crises sanitaires, mondialisation, inégalités...) des « Moyens », qui sont les indicateurs de santé. (cf. p.6)

76. Dans une région, on dénombre 150 000 naissances vivantes sur une année, parmi lesquelles 555 enfants sont décédés avant l'âge de 1 an.

a) Le taux de mortalité infantile de cette région est de 3,7 ‰. — **VRAI**

Taux de mortalité infantile = décès avant 1 an / naissances vivantes × 1000 = 555 / 150000 × 1000 = 3,7 ‰. (cf. p.12)

b) Le taux de mortalité infantile de cette région est de 37,0 ‰. — **FAUX**

Le taux exact est de 3,7 ‰ ; 37,0 ‰ correspond à une erreur d'un facteur 10. (cf. p.12)

c) Le taux de mortalité infantile se calcule en rapportant le nombre de décès avant 1 an au nombre de naissances vivantes. — **VRAI**

C'est la définition exacte donnée par le cours. (cf. p.12)

d) Le taux de mortalité infantile se calcule en rapportant le nombre de décès avant 1 an à la population totale. — **FAUX**

C'est le nombre de naissances vivantes qui sert de dénominateur, pas la population totale. (cf. p.12)

e) Le taux national de mortalité infantile était de 4,1 ‰ en France en 2024. — **VRAI**

Valeur donnée par le cours pour l'année 2024 en France. (cf. p.12)

77. Concernant l'histoire et la structuration de la santé publique :

a) La vaccination contre la variole a été mise au point par Louis Pasteur en 1848, sur le principe de pasteurisation. — **FAUX**

Le cours attribue la vaccination contre la variole (1796, principe d'inoculation) à Edward Jenner, distincte des travaux de Pasteur. (cf. p.4)

b) La loi relative à la protection de la santé publique, en 1902, a introduit le concept de santé publique en France. — **VRAI**

Le cours date cette loi de 1902, distincte de la définition de l'OMS qui date de 1952. (cf. p.4)

c) Le Serment d'Hippocrate concerne exclusivement l'organisation administrative des hôpitaux modernes. — **FAUX**

Le cours associe le Serment d'Hippocrate à la déontologie de la pratique médicale et aux soins gratuits à l'indigent. (cf. p.4)

d) Les hôpitaux-Dieu étaient des établissements créés au 19e siècle par l'État pour la recherche médicale. — **FAUX**

Le cours situe la création des hôpitaux-Dieu au Moyen Âge, tenus par des ordres religieux. (cf. p.4)

e) Le courant hygiéniste (19e-début 20e siècle) correspond à l'abandon des mesures d'hygiène au profit de traitements uniquement curatifs. — **FAUX**

Le cours définit le courant hygiéniste comme l'émergence de l'épidémiologie, de l'hygiène et de la prévention. (cf. p.4)

78. Concernant les sources de données en santé publique :

a) L'Inserm ne figure pas parmi les sources de données citées par le cours pour les causes de décès. —

FAUX

Le cours cite explicitement « CépiDc, Inserm » comme sources pour la centralisation et l'analyse des causes de décès. (cf. p.8)

b) Les informations des registres des cancers proviennent exclusivement des déclarations spontanées des patients. — **FAUX**

Le cours cite trois sources professionnelles : anatomo-pathologistes, biologistes, cliniciens. (cf. p.9)

c) Les maladies à déclaration obligatoire (MDO) et les données démographiques (Insee, INED) font partie des sources de données en santé publique en France. — **VRAI**

Le cours liste les MDO et les données démographiques (Insee, INED) parmi les différentes sources de données françaises. (cf. p.8)

d) Le big data en santé se caractérise par une explosion quantitative des données numériques et une haute technicité. — **VRAI**

Le cours décrit au contraire une « explosion quantitative des données numériques ». (cf. p.8)

e) Le CépiDc est un registre exclusivement dédié aux cancers colorectaux. — **FAUX**

Le CépiDc centralise les causes de décès (accès libre sur internet), pas spécifiquement les cancers colorectaux (ce sont les registres des cancers). (cf. p.8)

79. Concernant la prévalence, l'incidence et la létalité :

a) Comparés aux femmes, les hommes déclarent moins souffrir d'une maladie, alors qu'ils sont pourtant les plus atteints de maladies. — **VRAI**

Le cours souligne un paradoxe : les hommes déclarent moins souffrir de maladies, bien qu'ils soient les plus atteints. (cf. p.10)

b) La prévalence correspond au nombre de cas sur une période de temps ou à un moment donné, et reflète l'importance quantitative de la maladie. — **VRAI**

Le nombre de nouveaux cas correspond à l'incidence, non à la prévalence, qui reflète le nombre de cas total à un instant ou sur une période. (cf. p.11)

c) La morbidité fait référence exclusivement aux décès, sans lien avec les maladies. — **FAUX**

Le cours définit la morbidité comme faisant référence aux maladies et pathologies ; les décès relèvent de la mortalité. (cf. p.10)

d) Les 3 types de morbidité sont la morbidité aiguë, la morbidité chronique et la morbidité mixte. — **FAUX**

Le cours cite précisément : morbidité ressentie, morbidité diagnostiquée, morbidité réelle. (cf. p.10)

e) La mortalité, et non l'incidence, est l'indicateur qui permet de savoir s'il y a épidémie ou non. —

FAUX

Le cours associe explicitement l'incidence à la question « épidémie ou non ». (cf. p.11)

80. Concernant l'histoire et la structuration de la santé publique :

a) L'épidémie de peste noire a débuté en 1347 à Marseille et a causé 30 à 50 % de décès en Europe. — **VRAI**

Le cours date la peste noire de 1347, à Marseille, avec 30-50 % de décès en Europe. (cf. p.4)

b) La vaccination contre la variole a été mise au point par Louis Pasteur en 1848, sur le principe de pasteurisation. — **FAUX**

Le cours attribue la vaccination contre la variole (1796, principe d'inoculation) à Edward Jenner, distincte des travaux de Pasteur. (cf. p.4)

c) Le Serment d'Hippocrate concerne exclusivement l'organisation administrative des hôpitaux modernes. — **FAUX**

Le cours associe le Serment d'Hippocrate à la déontologie de la pratique médicale et aux soins gratuits à l'indigent. (cf. p.4)

d) Le courant hygiéniste (19e-début 20e siècle) correspond à l'émergence de l'épidémiologie, de l'hygiène et de la prévention. — **VRAI**

Le cours définit le courant hygiéniste comme l'émergence de l'épidémiologie, de l'hygiène et de la prévention. (cf. p.4)

e) Louis Pasteur est associé exclusivement à la création des hôpitaux-Dieu au Moyen Âge. — **FAUX**

Le cours associe Pasteur à l'hypothèse des agents infectieux, la pasteurisation et l'asepsie chirurgicale, pas aux hôpitaux-Dieu (Moyen Âge). (cf. p.4)

Série 5 — Correction (Questions 81 à 100)

81. Au cours d'une épidémie, 800 personnes ont été atteintes par une maladie donnée ; parmi elles, 40 en sont décédées.

- a) La létalité de cette maladie, dans cette population, est de 5,0 %. — **VRAI**
Létalité = décès parmi les malades / nombre de malades = 40 / 800 = 5,0 %. (cf. p.11)
- b) La létalité de cette maladie, dans cette population, est de 50,0 %. — **FAUX**
La létalité exacte est de 5,0 % ; 50,0 % correspond à une erreur d'un facteur 10. (cf. p.11)
- c) La létalité correspond au nombre de décès parmi les malades. — **VRAI**
C'est la définition exacte donnée par le cours. (cf. p.11)
- d) La létalité informe sur la dynamique de la maladie plutôt que sur sa gravité. — **FAUX**
La létalité informe sur la gravité de la maladie ; c'est l'incidence qui informe sur sa dynamique. (cf. p.11)
- e) Le taux de reproduction R de cette épidémie correspond aux cas secondaires engendrés par un cas, et non à la létalité. — **VRAI**
Le taux de reproduction R (cas secondaires engendrés par un cas) est un indicateur distinct de la létalité, qui informe sur la contagiosité. (cf. p.11)

82. Dans une région, on dénombre 340 000 naissances vivantes sur une année, parmi lesquelles 1 190 enfants sont décédés avant l'âge de 1 an.

- a) Le taux de mortalité infantile de cette région est de 3,5 ‰. — **VRAI**
Taux de mortalité infantile = décès avant 1 an / naissances vivantes × 1000 = 1190 / 340000 × 1000 = 3,5 ‰. (cf. p.12)
- b) Le taux de mortalité infantile de cette région est de 35,0 ‰. — **FAUX**
Le taux exact est de 3,5 ‰ ; 35,0 ‰ correspond à une erreur d'un facteur 10. (cf. p.12)
- c) Le taux de mortalité infantile se calcule en rapportant le nombre de décès avant 1 an au nombre de naissances vivantes. — **VRAI**
C'est la définition exacte donnée par le cours. (cf. p.12)
- d) Le taux de mortalité infantile se calcule en rapportant le nombre de décès avant 1 an à la population totale. — **FAUX**
C'est le nombre de naissances vivantes qui sert de dénominateur, pas la population totale. (cf. p.12)
- e) Le taux national de mortalité infantile était de 4,1 ‰ en France en 2024. — **VRAI**
Valeur donnée par le cours pour l'année 2024 en France. (cf. p.12)

83. Au cours d'une épidémie, 1000 personnes ont été atteintes par une maladie donnée ; parmi elles, 30 en sont décédées.

- a) La létalité de cette maladie, dans cette population, est de 3,0 %. — **VRAI**
Létalité = décès parmi les malades / nombre de malades = 30 / 1000 = 3,0 %. (cf. p.11)
- b) La létalité de cette maladie, dans cette population, est de 30,0 %. — **FAUX**
La létalité exacte est de 3,0 % ; 30,0 % correspond à une erreur d'un facteur 10. (cf. p.11)
- c) La létalité correspond au nombre de décès parmi les malades. — **VRAI**
C'est la définition exacte donnée par le cours. (cf. p.11)
- d) La létalité informe sur la dynamique de la maladie plutôt que sur sa gravité. — **FAUX**
La létalité informe sur la gravité de la maladie ; c'est l'incidence qui informe sur sa dynamique. (cf. p.11)
- e) Le taux de reproduction R de cette épidémie correspond aux cas secondaires engendrés par un cas, et non à la létalité. — **VRAI**
Le taux de reproduction R (cas secondaires engendrés par un cas) est un indicateur distinct de la létalité, qui informe sur la contagiosité. (cf. p.11)

84. Concernant la prévalence, l'incidence et la létalité :

a) Selon l'enquête Insee 2002-2003, les femmes se trouvent plus souvent en très bonne santé que les hommes. — **FAUX**

Le cours indique 28,2 % des hommes contre 21,5 % des femmes en très bonne santé, donc un avantage masculin sur ce critère. (cf. p.10)

b) La létalité correspond au nombre de décès parmi les malades, et informe sur la gravité de la maladie. — **VRAI**

Le nombre de cas à un moment donné correspond à la prévalence, pas à la létalité qui mesure les décès parmi les malades. (cf. p.11)

c) La prévalence correspond exclusivement au nombre de nouveaux cas sur une période de temps. — **FAUX**

Le nombre de nouveaux cas correspond à l'incidence, non à la prévalence, qui reflète le nombre de cas total à un instant ou sur une période. (cf. p.11)

d) L'incidence permet notamment de savoir s'il y a épidémie ou non. — **VRAI**

Le cours associe explicitement l'incidence à la question « épidémie ou non ». (cf. p.11)

e) Comparés aux femmes, les hommes déclarent moins souffrir d'une maladie, alors qu'ils sont pourtant les plus atteints de maladies. — **VRAI**

Le cours souligne un paradoxe : les hommes déclarent moins souffrir de maladies, bien qu'ils soient les plus atteints. (cf. p.10)

85. Concernant la mortalité en France :

a) En France, on compte 600 000 à 650 000 décès par an, avec 646 000 décès en 2024 (augmentation de 6 700 par rapport à 2023). — **VRAI**

Le cours indique précisément 646 000 décès en 2024, en augmentation de 6 700 par rapport à 2023 (639 300). (cf. p.12)

b) Entre 1980 et 2004, les décès liés aux maladies tumorales et aux cancers ont diminué aussi fortement que ceux liés aux maladies cardiovasculaires. — **FAUX**

Le cours oppose la diminution des décès cardiovasculaires à la « très grande stabilité » des décès tumoraux/cancers. (cf. p.13)

c) Le taux brut de mortalité se calcule en divisant le nombre de décès par le nombre de naissances vivantes. — **FAUX**

Diviser les décès par les naissances vivantes correspond au calcul du taux de mortalité infantile, pas du taux brut de mortalité (décès/population). (cf. p.12)

d) En 2022, les maladies cardiovasculaires représentaient environ 24 % des décès en France et étaient la première cause de mortalité chez les hommes. — **FAUX**

Le cours attribue aux maladies cardiovasculaires le rang de 1ère cause de mortalité chez les femmes, non chez les hommes (où ce sont les tumeurs). (cf. p.13)

e) En 2022, le nombre de décès en France a fortement diminué par rapport aux années précédentes, sans lien avec des causes sanitaires particulières. — **FAUX**

Le cours indique 670 000 décès en 2022, en augmentation, liée au Covid, à la grippe et à la canicule. (cf. p.12)

86. Dans une région, on dénombre 200 000 naissances vivantes sur une année, parmi lesquelles 780 enfants sont décédés avant l'âge de 1 an.

a) Le taux de mortalité infantile de cette région est de 3,9 ‰. — **VRAI**

Taux de mortalité infantile = décès avant 1 an / naissances vivantes × 1000 = 780 / 200000 × 1000 = 3,9 ‰. (cf. p.12)

b) Le taux de mortalité infantile de cette région est de 39,0 ‰. — **FAUX**

Le taux exact est de 3,9 ‰ ; 39,0 ‰ correspond à une erreur d'un facteur 10. (cf. p.12)

c) Le taux de mortalité infantile se calcule en rapportant le nombre de décès avant 1 an au nombre de naissances vivantes. — **VRAI**

C'est la définition exacte donnée par le cours. (cf. p.12)

d) Le taux de mortalité infantile se calcule en rapportant le nombre de décès avant 1 an à la population totale. — **FAUX**

C'est le nombre de naissances vivantes qui sert de dénominateur, pas la population totale. (cf. p.12)

e) Le taux national de mortalité infantile était de 4,1 ‰ en France en 2024. — **VRAI**

Valeur donnée par le cours pour l'année 2024 en France. (cf. p.12)

87. Concernant les indicateurs de santé :

a) Les seuls types d'indicateurs de santé reconnus par le cours sont la mortalité et la morbidité. —

FAUX

Le cours cite cinq types : mortalité, morbidité, facteurs de risque, handicap, démographiques (ces derniers parfois ajoutés). (cf. p.7)

b) La fiabilité (ou reproductibilité) fait partie des propriétés des indicateurs de santé. — **VRAI**

La fiabilité/reproductibilité est listée comme une propriété générale des indicateurs de santé, sans restriction aux seuls indicateurs de mortalité. (cf. p.7)

c) La complexité d'usage est présentée comme une propriété recherchée des indicateurs de santé. —

FAUX

Le cours cite la disponibilité, la simplicité à l'usage, la fiabilité et l'exactitude comme propriétés recherchées, pas la complexité. (cf. p.7)

d) Les indicateurs de santé fournissent des éléments indispensables à la connaissance de l'importance des problèmes de santé, à la prise de décision et à l'orientation de la recherche étiologique. — **VRAI**

Le cours cite trois apports indispensables des indicateurs de santé : connaissance des problèmes, prise de décision, orientation de la recherche étiologique. (cf. p.7)

e) Un indicateur de santé est une donnée brute individuelle, non agrégée, propre à un seul patient. —

FAUX

La définition du cours insiste sur l'agrégation, la simplification ou le résumé d'ensembles d'informations, pas sur une donnée individuelle brute. (cf. p.7)

88. Dans une région, on dénombre 630 000 naissances vivantes sur une année, parmi lesquelles 2 772 enfants sont décédés avant l'âge de 1 an.

a) Le taux de mortalité infantile de cette région est de 4,4 ‰. — **VRAI**

Taux de mortalité infantile = décès avant 1 an / naissances vivantes × 1000 = 2772 / 630000 × 1000 = 4,4 ‰. (cf. p.12)

b) Le taux de mortalité infantile de cette région est de 44,0 ‰. — **FAUX**

Le taux exact est de 4,4 ‰ ; 44,0 ‰ correspond à une erreur d'un facteur 10. (cf. p.12)

c) Le taux de mortalité infantile se calcule en rapportant le nombre de décès avant 1 an au nombre de naissances vivantes. — **VRAI**

C'est la définition exacte donnée par le cours. (cf. p.12)

d) Le taux de mortalité infantile se calcule en rapportant le nombre de décès avant 1 an à la population totale. — **FAUX**

C'est le nombre de naissances vivantes qui sert de dénominateur, pas la population totale. (cf. p.12)

e) Le taux national de mortalité infantile était de 4,1 ‰ en France en 2024. — **VRAI**

Valeur donnée par le cours pour l'année 2024 en France. (cf. p.12)

89. Concernant les définitions de la santé :

a) Selon le chirurgien René Leriche (1936), « la santé c'est la vie dans le bruit des organes ». — **FAUX**

La citation exacte de Leriche (1936) est : « la santé c'est la vie dans le silence des organes ». (cf. p.1)

b) Selon l'OMS, la santé est la finalité ultime de la vie, un but à atteindre et non une ressource. — **FAUX**

Le cours précise que « la santé est une ressource pour chaque jour de la vie, et n'est pas une finalité de la vie ». (cf. p.2)

c) Selon Canguilhem, la notion de santé n'a jamais eu de rapport avec la notion religieuse de salut. —

FAUX

Canguilhem écrit explicitement que « la santé a remplacé le salut » et qu'être en bonne santé « c'est un luxe biologique ». (cf. p.1)

d) Selon Steichen, la santé correspond à l'absence totale de toute variabilité individuelle. — **FAUX**

La citation de Steichen indique que la santé « correspond à la normalité avec ses caractéristiques ». (cf. p.1)

e) Selon l'OMS, la santé se définit exclusivement par l'absence de maladie ou d'infirmité. — **FAUX**

La définition de l'OMS précise explicitement que la santé « ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité ». (cf. p.2)

90. Concernant l'histoire et la structuration de la santé publique :

a) Le courant hygiéniste (19e-début 20e siècle) correspond à l'émergence de l'épidémiologie, de l'hygiène et de la prévention. — **VRAI**

Le cours définit le courant hygiéniste comme l'émergence de l'épidémiologie, de l'hygiène et de la prévention. (cf. p.4)

b) La loi relative à la protection de la santé publique date de 1952, année de la définition de l'OMS. — **FAUX**

Le cours date cette loi de 1902, distincte de la définition de l'OMS qui date de 1952. (cf. p.4)

c) Le Serment d'Hippocrate pose la déontologie de la pratique médicale, avec notamment des soins gratuits à l'indigent. — **VRAI**

Le cours associe le Serment d'Hippocrate à la déontologie de la pratique médicale et aux soins gratuits à l'indigent. (cf. p.4)

d) L'épidémie de peste noire a débuté en 1347 à Marseille et a causé 30 à 50 % de décès en Europe. — **VRAI**

Le cours date la peste noire de 1347, à Marseille, avec 30-50 % de décès en Europe. (cf. p.4)

e) La vaccination contre la variole a été mise au point par Edward Jenner en 1796, sur le principe d'inoculation. — **VRAI**

Le cours attribue la vaccination contre la variole (1796, principe d'inoculation) à Edward Jenner, distincte des travaux de Pasteur. (cf. p.4)

91. Concernant les sources de données en santé publique :

a) Le CépiDc est une source de données sur les causes de décès en France, en accès libre sur internet. — **VRAI**

Le CépiDc centralise les causes de décès (accès libre sur internet), pas spécifiquement les cancers colorectaux (ce sont les registres des cancers). (cf. p.8)

b) Le big data en santé se caractérise par une diminution du volume de données disponibles. — **FAUX**

Le cours décrit au contraire une « explosion quantitative des données numériques ». (cf. p.8)

c) Il existe 25 registres des cancers en France, dont 14 registres généraux et 11 registres spécialisés. — **VRAI**

Le cours indique 25 registres au total en France : 14 généraux et 11 spécialisés. (cf. p.9)

d) Les informations des registres des cancers proviennent des anatomo-pathologistes, des biologistes et des cliniciens. — **VRAI**

Le cours cite trois sources professionnelles : anatomo-pathologistes, biologistes, cliniciens. (cf. p.9)

e) La population de référence des registres des cancers est le plus souvent celle du département. — **VRAI**

Le cours précise que la population de référence est « le plus souvent » celle du département, pas systématiquement le territoire national. (cf. p.9)

92. Concernant la règle des 5P et la santé publique :

a) Selon l'OMS (2002), la santé publique se limite aux efforts d'institutions privées à but lucratif. — **FAUX**

Le cours attribue cette définition (2002) à des « institutions publiques », par une action collective. (cf. p.5)

b) En tant que discipline autonome, la santé publique s'occupe exclusivement de l'état de santé individuel d'un patient donné. — **FAUX**

Le cours définit la santé publique comme s'occupant de la santé globale des populations, non d'un individu isolé. (cf. p.5)

c) Selon l'OMS (1952), l'objet final de la santé publique est de permettre à chaque individu de jouir de son droit inné à la santé et à la longévité. — **VRAI**

Le cours précise que « l'objet final [est] de permettre à chaque individu de jouir de son droit inné à la santé et à la longévité ». (cf. p.3)

d) Selon l'OMS (1952), organiser des services médicaux et infirmiers en vue du diagnostic précoce et du traitement préventif des maladies fait partie de l'action collective concertée. — **VRAI**

Le cours liste explicitement « organiser des services médicaux et infirmiers en vue du diagnostic précoce et du traitement préventif des maladies » parmi les actions visées. (cf. p.3)

e) Dans la règle des 5P, la Prévention vise à enrayer la propagation de maladies déjà présentes, par la gestion des urgences sanitaires. — **FAUX**

Éviter la survenue de maladies (vaccination, dépistage) correspond à la Prévention ; enrayer la propagation correspond à la Protection. (cf. p.5)

93. Concernant la complémentarité entre médecine clinique et santé publique :

- a) La médecine clinique prend en charge une personne, ce que le cours nomme un « colloque singulier ». — **VRAI**

Le « colloque singulier » désigne la prise en charge d'une personne par la médecine clinique, non l'approche par populations de la santé publique. (cf. p.6)

- b) Parmi les crises sanitaires passées justifiant de mesurer l'état de santé figurent l'amiante (1970), le sang contaminé (1983) et le Covid (2020). — **VRAI**

Le cours cite plusieurs crises antérieures au Covid : amiante (1970), hormone de croissance (1980), sang contaminé (1983), ESB (1985-1991), canicule (2003). (cf. p.6)

- c) Les indicateurs de santé sont présentés comme le moyen utilisé pour mesurer et observer l'état de santé. — **VRAI**

Le cours distingue les « Raisons » (crises sanitaires, mondialisation, inégalités...) des « Moyens », qui sont les indicateurs de santé. (cf. p.6)

- d) Contrairement à la santé publique, la médecine clinique s'intéresse en priorité à des groupes de personnes plutôt qu'à un patient individuel. — **FAUX**

C'est la santé publique qui s'intéresse aux groupes de personnes ; la médecine clinique prend en charge une personne. (cf. p.6)

- e) Selon C. Everett Koop, les soins de santé (health care) sont vitaux à tous, tout le temps, alors que la santé publique ne l'est qu'occasionnellement. — **FAUX**

La citation de Koop inverse ces deux rôles : « health care is vital to all of us some of the time, but public health is vital to all of us all of the time ». (cf. p.6)

94. En 2023 en France, l'espérance de vie à la naissance était de 80,0 ans pour les hommes et de 85,7 ans pour les femmes.

- a) L'écart d'espérance de vie entre les sexes, en 2023, est de 5,7 ans. — **VRAI**

$85,7 - 80,0 = 5,7$ ans. (cf. p.14)

- b) L'écart d'espérance de vie entre les sexes, en 2023, est de 7,7 ans. — **FAUX**

L'écart exact est de 5,7 ans ($85,7 - 80,0$), pas 7,7 ans. (cf. p.14)

- c) Cet écart s'est réduit par rapport à 1997, où il était de 7,8 ans. — **VRAI**

Le cours indique un écart de 7,8 ans en 1997, contre 5,9 ans en 2022 : une réduction progressive. (cf. p.14)

- d) Cet écart s'est creusé par rapport à 1997, où il était de 7,8 ans. — **FAUX**

L'écart s'est réduit, et non creusé, depuis 1997 (7,8 ans) jusqu'en 2022 (5,9 ans). (cf. p.14)

- e) Cette réduction de l'écart s'explique notamment par des facteurs de risque désormais similaires entre hommes et femmes (alcool, tabac, sédentarité). — **VRAI**

Le cours cite cette explication : avancée de la science médicale pour tous et facteurs de risque des femmes désormais identiques à ceux des hommes. (cf. p.14)

95. Concernant les causes de mortalité en France :

- a) Entre 1980 et 2004, les décès liés aux maladies tumorales et aux cancers sont restés d'une très grande stabilité. — **VRAI**

Le cours oppose la diminution des décès cardiovasculaires à la « très grande stabilité » des décès tumoraux/cancers. (cf. p.13)

- b) La mortalité toutes causes des hommes est plus importante que celle des femmes, pour toutes les classes d'âge. — **VRAI**

Le cours décrit une surmortalité masculine globale, pour toutes les classes d'âge, et non une surmortalité féminine. (cf. p.12)

- c) En 2022, le nombre de décès en France a fortement diminué par rapport aux années précédentes, sans lien avec des causes sanitaires particulières. — **FAUX**

Le cours indique 670 000 décès en 2022, en augmentation, liée au Covid, à la grippe et à la canicule. (cf. p.12)

- d) En France, on compte 600 000 à 650 000 décès par an, avec 600 000 décès en 2024 (diminution par rapport à 2023). — **FAUX**

Le cours indique précisément 646 000 décès en 2024, en augmentation de 6 700 par rapport à 2023 (639 300). (cf. p.12)

- e) Le taux de mortalité infantile en France est en augmentation, passant de 3,6 ‰ en 2018 à 4,1 ‰ en 2024. — **VRAI**

Le cours décrit une augmentation du taux de mortalité infantile, de 3,6 ‰ (2018) à 4,1 ‰ (2024). (cf. p.15)

96. Concernant la complémentarité entre médecine clinique et santé publique :

a) La santé publique repose exclusivement sur des méthodes thérapeutiques individuelles, à l'exclusion de l'épidémiologie. — **FAUX**

Le tableau attribue les méthodes thérapeutiques à la médecine clinique, et l'épidémiologie/administration de la santé/sociologie à la santé publique. (cf. p.6)

b) Selon C. Everett Koop, les soins de santé (health care) sont vitaux à tous, tout le temps, alors que la santé publique ne l'est qu'occasionnellement. — **FAUX**

La citation de Koop inverse ces deux rôles : « health care is vital to all of us some of the time, but public health is vital to all of us all of the time ». (cf. p.6)

c) La médecine clinique et la santé publique ont exactement le même objet, la maladie. — **FAUX**

Le tableau de comparaison oppose « traiter la maladie » (médecine clinique) à « traiter de la santé » (santé publique). (cf. p.6)

d) Les maladies d'importation sont présentées comme sans lien avec le phénomène de mondialisation. — **FAUX**

Le cours classe explicitement les maladies d'importation et la réémergence de maladies parmi les « conséquences de la mondialisation ». (cf. p.6)

e) Contrairement à la santé publique, la médecine clinique s'intéresse en priorité à des groupes de personnes plutôt qu'à un patient individuel. — **FAUX**

C'est la santé publique qui s'intéresse aux groupes de personnes ; la médecine clinique prend en charge une personne. (cf. p.6)

97. Concernant la mortalité en France :

a) Le taux de mortalité infantile se calcule en divisant le nombre de décès avant l'âge de 1 an par la population totale. — **FAUX**

Le calcul officiel du cours divise les décès avant 1 an par le nombre de naissances vivantes, pas par la population totale (ce qui correspond au taux brut de mortalité). (cf. p.12)

b) En 2022, les tumeurs représentaient environ 27 % des décès en France et étaient la première cause de mortalité chez les hommes. — **VRAI**

Le cours précise que les tumeurs sont la 1ère cause de mortalité chez les hommes, alors que les maladies cardiovasculaires sont la 1ère cause chez les femmes. (cf. p.13)

c) Avant 65 ans, les décès sont systématiquement considérés comme naturels et liés au vieillissement. — **FAUX**

Le cours situe ce seuil à 65 ans ; avant cet âge, il évoque une capacité d'accompagner les gens pour qu'ils ne meurent pas, non une mortalité considérée comme naturelle. (cf. p.12)

d) Entre 1980 et 2004, les décès liés aux maladies cardiovasculaires ont diminué, notamment grâce au développement de thérapeutiques et à l'installation de défibrillateurs. — **VRAI**

Le cours décrit une diminution des décès cardiovasculaires sur cette période, liée aux progrès thérapeutiques. (cf. p.13)

e) Le taux brut de mortalité se calcule en divisant le nombre de décès par le nombre de naissances vivantes. — **FAUX**

Diviser les décès par les naissances vivantes correspond au calcul du taux de mortalité infantile, pas du taux brut de mortalité (décès/population). (cf. p.12)

98. Concernant la prévalence, l'incidence et la létalité :

- a) Les hommes déclarent davantage souffrir de maladies que les femmes, en cohérence avec une prévalence plus élevée chez eux. — **FAUX**

Le cours souligne un paradoxe : les hommes déclarent moins souffrir de maladies, bien qu'ils soient les plus atteints. (cf. p.10)

- b) La morbidité fait référence exclusivement aux décès, sans lien avec les maladies. — **FAUX**

Le cours définit la morbidité comme faisant référence aux maladies et pathologies ; les décès relèvent de la mortalité. (cf. p.10)

- c) La mortalité, en épidémiologie descriptive, correspond au nombre de décès, mesuré par des indicateurs de mortalité brute ou spécifique. — **VRAI**

Le nombre de nouveaux cas correspond à l'incidence, non à la mortalité qui correspond au nombre de décès. (cf. p.11)

- d) L'incidence permet notamment de savoir s'il y a épidémie ou non. — **VRAI**

Le cours associe explicitement l'incidence à la question « épidémie ou non ». (cf. p.11)

- e) L'incidence correspond au nombre de décès parmi les malades, et informe sur la gravité de la maladie. — **FAUX**

Le nombre de décès parmi les malades correspond à la létalité (gravité), pas à l'incidence (dynamique/nouveaux cas). (cf. p.11)

99. Concernant la morbidité et les indicateurs de morbidité :

- a) La létalité correspond au nombre de cas à un moment donné, et informe sur l'importance quantitative de la maladie. — **FAUX**

Le nombre de cas à un moment donné correspond à la prévalence, pas à la létalité qui mesure les décès parmi les malades. (cf. p.11)

- b) La portion de population se trouvant en très bonne santé augmente continûment avec l'âge. — **FAUX**

Le cours décrit une diminution de la très bonne santé perçue avec l'augmentation de l'âge, et non une augmentation. (cf. p.10)

- c) La prévalence correspond exclusivement au nombre de nouveaux cas sur une période de temps. — **FAUX**

Le nombre de nouveaux cas correspond à l'incidence, non à la prévalence, qui reflète le nombre de cas total à un instant ou sur une période. (cf. p.11)

- d) Selon l'enquête Insee 2002-2003, les femmes se trouvent plus souvent en très bonne santé que les hommes. — **FAUX**

Le cours indique 28,2 % des hommes contre 21,5 % des femmes en très bonne santé, donc un avantage masculin sur ce critère. (cf. p.10)

- e) Les 3 types de morbidité sont la morbidité aiguë, la morbidité chronique et la morbidité mixte. — **FAUX**

Le cours cite précisément : morbidité ressentie, morbidité diagnostiquée, morbidité réelle. (cf. p.10)

100. Concernant la mortalité infantile et l'indice synthétique de fécondité :

- a) L'indice synthétique de fécondité (ISF) désigne le nombre d'enfants par femme, et son seuil de remplacement est de 2,1. — **VRAI**

Le cours définit l'ISF comme le nombre d'enfants par femme, avec un seuil de remplacement de 2,1, distinct du taux de fécondité (rapport au nombre de femmes en âge de procréer). (cf. p.15)

- b) Si l'ISF est inférieur au seuil de remplacement, une diminution de la population à long terme est possible, sans apport migratoire. — **VRAI**

Le cours indique qu'un ISF sous le seuil de remplacement rend possible une diminution de la population sans apport migratoire, pas une augmentation garantie. (cf. p.15)

- c) Entre 2009 et 2023, la population française a augmenté (de 62,6 à 68,4 millions d'habitants) alors que l'indice synthétique de fécondité a diminué (de 2,0 à 1,68). — **VRAI**

Le cours indique une hausse de la population (62,6 à 68,4 millions) et une baisse de l'ISF (2,0 à 1,68) sur cette période, soit l'inverse. (cf. p.15)

- d) La fiabilité (ou reproductibilité) est présentée comme une propriété exclusive des seuls indicateurs de mortalité. — **FAUX**

La fiabilité/reproductibilité est listée comme une propriété générale des indicateurs de santé, sans restriction aux seuls indicateurs de mortalité. (cf. p.7)

- e) La population de référence des registres des cancers est le plus souvent celle du département. — **VRAI**

Le cours précise que la population de référence est « le plus souvent » celle du département, pas systématiquement le territoire national. (cf. p.9)